

СЕМИНАР «ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0» ·  
МИНТРУД РОССИИ · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25–27 АВГУСТА  
2026

# Сколько стоит достойная жизнь

Мировой опыт реформирования психоневрологических интернатов: что можно сделать на имеющиеся деньги, какой объём социальных услуг реально предоставить и куда движутся лучшие системы заботы.

**Доклад для руководителей организаций социального обслуживания и региональных министров**

Материал к третьему докладу семинара

8 передовых моделей · 5 дорогих ошибок · 8 российских пилотов · калькулятор региона

Источники: ОЭСР, Bundesgesundheitsministerium, MHLW, NHS England, Housing LIN, Y-Foundation, НИУ ВШЭ, Минтруд России, рецензируемые журналы

Подготовлено для участников семинара. Каждая цифра сопровождается источником; расчётные оценки помечены отдельно. Деньги приводятся в валюте страны и в пересчёте там, где это нужно для сравнения.

# Содержание

## Как читать этот доклад **с. 4**

Резюме для министра · Резюме для директора

## Часть 1. Постановка задачи: интернат — это не больница **с. 7**

- 1.1. О ком этот доклад: 160–220 тысяч жителей ПНИ
- 1.2. Четыре единицы заботы: койка, место, час, квартира
- 1.3. Почему «мы хотим как в Америке» — не аргумент
- 1.4. Карта доклада

## Часть 2. Лестница возможностей: сколько денег мир тратит на заботу **с. 10**

- 2.1. От 0,2% до 3,9% ВВП: разброс в 20 раз
- 2.2. Три этажа мировой системы заботы
- 2.3. Цена часа ухода — и почему она не падает
- 2.4. Где Россия на этой лестнице
- 2.5. Арифметика для министра: честный ответ на «хотим как в Германии»

## Часть 3. Передовые модели: что куплено за эти деньги **с. 15**

- 3.1. Нидерланды: деревня Хохевейк и самая дорогая забота мира
- 3.2. Германия: Pflegeversicherung — отдельная страховка ухода
- 3.3. Япония: страхование ухода и армия кейс-менеджеров
- 3.4. Великобритания: сопровождаемое проживание и персональные бюджеты
- 3.5. Италия, Триест: город без психиатрической больницы
- 3.6. Финляндия: Housing First — сначала квартира, потом всё остальное
- 3.7. Дания: закон 1987 года и жильцы-наниматели с полной пенсией
- 3.8. Бразилия: деньги, которые пошли за человеком

## Часть 4. Дорогие ошибки: негативный опыт, который экономит нам миллиарды **с. 25**

- 4.1. США: деинституционализация без сообщества привела в тюрьму
- 4.2. Уинтербоурн-Вью: почему деньги и законы не сработали десять лет
- 4.3. Лерос: как потратить деньги Европы и не изменить ничего
- 4.4. Скандинавия: оборотная сторона успеха
- 4.5. Греция после Лероса: реформа без финансирования откатывается
- 4.6. Синтез: пять правил провала и пять правил успеха

## Часть 5. Россия: что уже происходит и сколько это стоит **с. 30**

- 5.1. Экономика ПНИ сегодня
- 5.2. 75% пенсии: датский взгляд на российскую норму
- 5.3. Правовая рамка: 137-ФЗ и пилот Минтруда
- 5.4. Восемь региональных кейсов
- 5.5. Разрыв охвата: два порядка между потенциалом и фактом
- 5.6. Карта барьеров: шесть стен, через которые идти

## **Часть 6. Калькулятор реформы для региона с. 38**

- 6.1. Цена единицы услуги: час, квартира, место, дом
- 6.2. Три сценария: сохранение, модернизация, трансформация
- 6.3. Условный регион N: считаем вместе
- 6.4. Шесть источников денег без новых денег
- 6.5. Переговорная таблица: запрос директора → мировая цена → наш аналог

## **Часть 7. Пространство новых идей: куда идти с. 44**

- 7.1. Мировой вектор 2035 года
- 7.2. Заделы на будущее: технологии, бюджеты, кооперативы
- 7.3. Корейский сценарий для России
- 7.4. Дорожная карта региона: пять шагов
- 7.5. Что можно сделать завтра без денег
- 7.6. Финал: почему это реально

## **Приложения с. 48**

А. Глоссарий · Б. Курсы валют · В. Методика оценки расходов России · Г. Источники

## Как читать этот доклад

Этот доклад написан не для Минздрава и не для любителей статистики. Он написан для людей, которые каждый день принимают решения о жизни других людей: для директоров психоневрологических интернатов и других организаций социального обслуживания — и для региональных министров, которые подписывают им бюджеты.

Вы приехали со всей страны, чтобы услышать новое о социальном обслуживании. Поэтому здесь нет одинаковых «паспортов стран» и скучных таблиц-простыней. Вместо этого — **истории реформ с ценниками**: сколько стоит забота в разных странах, что именно куплено на эти деньги, что сработало, а что провалилось и почему. Каждый кейс заканчивается коротким блоком «Что взять России».

Главный вопрос доклада прост: **что можно сделать на те деньги, которые уже есть?** У мира накоплен огромный опыт превращения интернатов-хранилищ в системы поддержки самостоятельной жизни. Оказалось, что это не только человечнее, но чаще всего и дешевле. Задача доклада — дать директорам понятную картину своих финансовых возможностей в мировой иерархии, а министрам — аргументы для предметного разговора о цене услуг.

**Договорённость о цифрах.** Все суммы приводятся в валюте страны (фунты, евро, иены, рубли) — так их легче проверить по первоисточнику. Для сравнения масштабов мы иногда переводим в понятные эквиваленты; курсы — в приложении Б. Расчётные оценки всегда помечены словом «оценка». Если цифра кажется вам невероятной — сначала посмотрите источник: он указан рядом.

### Резюме для министра: шесть тезисов

1. Уход как в Германии за деньги как вчера — **невозможен, и это арифметика, а не политика**. Германия тратит на уход €63,3 млрд в год (2024) при 5,6 млн получателей: это в среднем €11 300 на человека в год плюс тридцатилетняя страховая система. Зато **модель распределения** — кому час помощи, кому квартира, кому место в малом доме — копируется бесплатно.
2. **Поддержка жизни дешевле хранения — везде, где это измеряли.** Германия: стационар €26 978/год против амбулантной помощи €9 172/год. Великобритания: лечебное отделение £3 500/неделю против сопровождаемого жилья £1 569/неделю. Россия (оценка НИУ ВШЭ): ПНИ 8–24 тыс ₽/месяц против сопровождаемого проживания 2–6 тыс ₽/месяц.
3. **Потенциал российской реформы — десятки тысяч людей и миллиарды рублей.** Минтруд оценивает: до 45% подопечных ПНИ могли бы жить вне интерната. Это

70–100 тысяч человек. Сегодня в сопровождаемом проживании — менее 1 774 человек. Разрыв — два порядка.

4. **Ошибка дороже бездействия.** США сэкономили на закрытии больниц без строительства сообщества и получили 383 тысячи людей с тяжёлыми психическими расстройствами за решёткой: тюрьма обходится в \$31 000/год — втрое дороже помощи в сообществе (\$10 000/год).
5. **Реформа уже идёт в России — её нужно масштабировать, а не изобретать.** 84 региона практикуют элементы сопровождаемого проживания; пилот Минтруда в Воронежской и Нижегородской областях завершается в 2025 году. В Нижегородской области обследовали 350 жителей ПНИ: каждый пятый нуждается в сопровождении не более 12 часов в неделю — это цена двух рабочих визитов.
6. **Деньги без новых денег существуют.** Бразилия перенаправила финансирование из больниц в сообщество (с 24,8% до 79,4%). Финляндия экономит €9 600–15 000 в год на каждом бывшем бездомном. Челябинская область привлекла ВЭБ.РФ через проект социального воздействия. Шесть таких механизмов — в главе 6.4.

## Резюме для директора: шесть тезисов

1. **Ваш потолок определяется не желанием, а лестницей.** Мир тратит на длительный уход от 0,2% до 3,9% ВВП. Россия — оценочно 0,1–0,2%. Требовать «объёмы как в Америке» при российском бюджете нельзя — но можно требовать **другую организацию тех же денег**: это реально и доказано.
2. **Место в интернате — самая дорогая единица заботы после больничной койки.** Пока бюджет привязан к местам, а не к людям, система будет покупать места. Датчане решили это в 1987 году одним законом: жилец дома ухода — наниматель квартиры с полной пенсией.
3. **У каждого пятого вашего подопечного, возможно, потребность в 12 часах сопровождения в неделю.** Это не мечта — это обследование 350 жителей ПНИ в Нижегородской области. Начните с обследования: это дёшево и сразу даёт карту реальных потребностей.
4. **Лучшие дома мира маленькие.** Деревня Хохевейк: 6–7 жителей в доме, 23 дома, 250 сотрудников. Дания: отдельные квартиры с кухней и ванной. Курганская область: отделение на 14 мест. Масштаб дома — не признак бедности, а признак современности.
5. **Насилие и скандал начинаются там, где заканчивается прозрачность.** Уинтербоурн-Вью (Великобритания) и Лерос (Греция) — это истории не про злых людей, а про закрытые учреждения без внешних глаз. Открытость — самая дешёвая система безопасности.
6. **Семинар называется «Пространство новых идей» — и идеи в этом докладе рабочие.** Восемь моделей из шести стран, восемь российских пилотов, пять шагов

дорожной карты и восемь действий «завтра без денег» — в части 7.

## ЧАСТЬ 1

# Постановка задачи: интернат — это не больница

## 1.1. О ком этот доклад: 160–220 тысяч жителей ПНИ

В России в психоневрологических интернатах (ПНИ) живут, по разным оценкам, **160–220 тысяч человек**. Это взрослые люди с психическими расстройствами и интеллектуальными нарушениями, для которых интернат — не этап лечения, а дом на годы и десятилетия. Более 70% из них признаны судом недееспособными: решения об их жизни принимают другие. Государство удерживает у проживающего 75% пенсии в счёт оплаты проживания — человек остаётся с «карманными деньгами» и почти без личного имущества.

При этом ПНИ — не медицинская организация. Это принципиально для всего дальнейшего разговора. Психиатрическая больница лечит: у неё есть диагноз, курс, выписка. ПНИ **сопровождает жизнь**: суточное проживание, питание, помощь в быту, занятость, общение. Инструментарий больницы — врач и койка. Инструментарий интерната — сотрудник и час внимания. Путать эти две логики — значит покупать медицинские услуги там, где нужны социальные, и наоборот.

*Больница отвечает на вопрос «как вылечить?». Интернат должен отвечать на вопрос «как жить?». Весь мировой опыт реформ — это история о том, как системы учились честно отвечать на второй вопрос.*

Именно поэтому доклад говорит о **социальном обслуживании**, а не о психиатрии. Перед нами задача организации жизни беспомощных людей — такая же по природе, как задача ухода за пожилыми, за людьми с деменцией, с тяжёлой инвалидностью. Весь мир решает её в одном поле — long-term care (LTC), «длительный уход». И у мира есть 50 лет опыта её решения — с триумфами и катастрофами.

## 1.2. Четыре единицы заботы: койка, место, час, квартира

Когда министр и директор спорят об «объёме услуг», они часто говорят на разных языках, потому что «объём» измеряется четырьмя разными единицами. У каждой — своя цена и своё назначение.

Таблица 1.1. Четыре единицы заботы: назначение и ориентир цены

| Единица | Что покупаем | Кому подходит | Ориентир цены |
|---------|--------------|---------------|---------------|
|---------|--------------|---------------|---------------|

|                                         |                                                              |                                              |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Койка</b> (больница)                 | Лечение, наблюдение врача, безопасность в остром состоянии   | Обострение, кризис — недели, не годы         | Россия: 1 100–4 840 ₽/сутки                                                          |
| <b>Место</b> (интернат)                 | Проживание, питание, бытовое и медицинское обслуживание 24/7 | Тяжёлая зависимость, нет жилья и поддержки   | ПНИ: 8–24 тыс ₽/мес; частный ПНИ: 33–51 тыс ₽/мес; Великобритания: £1 186/нед        |
| <b>Час</b> (сопровождение)              | Помощь по дому, сопровождение, занятость — по потребности    | Живёт дома или в квартире, нужна поддержка   | Великобритания: £23,56/час; Нижний Новгород: у 20% жителей ПНИ потребность ≤12 ч/нед |
| <b>Квартира</b> (самостоятельная жизнь) | Своё жильё + выкупаемая поддержка                            | Большинство — после обучения и сопровождения | Финляндия: экономия €9 600–15 000/год; Россия: 2–6 тыс ₽/мес сопровождения           |

Вся мировая история реформ — это движение вниз по этой таблице: от койки к месту, от места к часу, от часа к квартире. Не потому, что так модно, а потому, что каждая следующая единица **дешевле и человечнее** для одного и того же человека — если его возможности позволяют. Искусство системы — распределять людей по единицам точно, не переплачивая за лишнюю опеку и не бросая нуждающегося.

**Почему это важно для спора о бюджете.** Когда директор требует «увеличить объём», уточните: какой? Мест — дорого. Часов — дешево. Квартир — почти бесплатно после старта. В Нижегородской области выяснилось, что каждый пятый житель ПНИ нуждается не в месте, а в 12 часах сопровождения в неделю. Разница в цене — кратная.

### 1.3. Почему «мы хотим как в Америке» — не аргумент

Фраза «в Америке объёмы услуг другие» звучит в кабинетах часто. Давайте посмотрим, что стоит за американской моделью — она поучительна ровно в противоположном смысле.

**383 000**

людей с тяжёлыми психическими расстройствами в тюрьмах и следственных изоляторах США (2014)

**× 10**

во столько раз их больше, чем пациентов всех оставшихся государственных психиатрических больниц

**3**

крупнейших «психиатрических учреждений» США — тюрьмы: Райкерс (Нью-Йорк), Твин-Тауэрс (Лос-Анджелес), Кук-Каунти (Чикаго)

**38%**

получают за решёткой хотя бы лекарства; психологическую помощь — единицы

США закрыли больницы, не построив сообщество, — и люди переехали из палат в камеры. Тюрьма стоит налогоплательщику около \$31 000 в год на человека; помощь в сообществе — около \$10 000. «Американская модель» — это не объёмы услуг, это отсутствие системы при максимальных ценах. Подробнее — в части 4.1.

Второй смысл, в котором «как в Америке» невозможно: **цена труда**. Час ухода стоит зарплату уходящего. В Великобритании час домашнего ухода обходится муниципалитету в £23,56 (2024/25). Никакая организационная хитрость не позволит купить час заботы дешевле часа труда заботливого человека. Поэтому единственный честный вопрос — не «почему у нас не как у них», а **«что мы можем купить на наш уровень цен — и купить максимум»**.

## 1.4. Карта доклада

- **Часть 2** — лестница: сколько денег у мира на заботу и где на этой лестнице Россия.
- **Часть 3** — восемь моделей, которые работают: Нидерланды, Германия, Япония, Великобритания, Италия, Финляндия, Дания, Бразилия. С ценами и уроками.
- **Часть 4** — пять дорогих ошибок: США, Великобритания (Уинтербоурн-Вью), Греция (Лерос), Скандинавия, снова Греция. Чужие потери — наша экономия.
- **Часть 5** — Россия сегодня: экономика ПНИ, закон, пилот Минтруда, восемь региональных кейсов.
- **Часть 6** — калькулятор: цена единицы услуги, три сценария для региона, шесть источников денег без новых денег, переговорная таблица.
- **Часть 7** — пространство новых идей: вектор 2035 года, корейский сценарий, дорожная карта и восемь действий завтрашнего дня.

## ЧАСТЬ 2

# Лестница возможностей: сколько денег мир тратит на заботу

## 2.1. От 0,2% до 3,9% ВВП: разброс в 20 раз

ОЭСР измеряет расходы стран на длительный уход (LTC): всё, что общество тратит на помощь людям, которые не могут справиться с повседневной жизнью самостоятельно, — от домов ухода до часов сиделки. В среднем по ОЭСР это **1,5% ВВП, или около \$760 на человека в год (2018)**. Но разброс огромный: Нидерланды — 3,9% ВВП, страны «семейной модели» — меньше 0,5%.



**Рисунок 2.1.** Расходы на длительный уход в % ВВП. Россия — авторская оценка (приложение В)

Что покупают страны на верхних ступенях? Не роскошь, а **формализацию заботы**: то, что в бедных странах бесплатно (и изнурительно) делают жёны, дочери и снохи, там делают обученные люди за зарплату. Разница между 0,2% и 3,9% ВВП — это разница между «уход = судьба семьи» и «уход = профессия и гарантированная услуга».

Важная деталь: деньги на LTC растут быстрее экономики почти везде. Причина — старение и честная арифметика: уход не автоматизируется. К этому мы ещё вернёмся в части 7 — это аргумент и для российской повестки.

## 2.2. Три этажа мировой системы заботы

### Этаж 1. Семья и хранилище

**0,1–0,5% ВВП**

Формального ухода почти нет: заботу несёт семья, для бездомных и одиноких — крупные закрытые учреждения-склады (Лерос-1989 — крайняя форма). Человек без семьи незащищён. Примеры: страны семейной модели ОЭСР; историческая Россия и Греция до реформ.

### Этаж 2. Страхование и квазирынок

**1–2,5% ВВП**

Уход — гарантированное право: отдельное страхование ухода (Германия, Япония, Корея) или муниципальная обязанность (Великобритания, Франция). Появляются часы помощи, персональные бюджеты, малые формы проживания. Интернаты существуют, но их доля и размер сокращаются.

### Этаж 3. Нормализованная жизнь

**3,5% ВВП и выше**

Нидерланды и Скандинавия: уход встроен в обычную жизнь. Деревня Хохевейк — магазин, театр, паб, дома на 6–7 жителей. Дания: жилец дома ухода — наниматель квартиры с полной пенсией. Интернат как тип учреждения исчезает.

Куда движется мир? С первого этажа через второй — к третьему. Причём движутся все, включая богатейшие: Скандинавия сокращает места в учреждениях уже двадцать лет, Нидерланды в 2015 году передали уход муниципалитетам и сбросили 8% расходов на стационарную помощь за один год. Движение необратимо — вопрос только в скорости и цене перехода.

## 2.3. Цена часа ухода — и почему она не падает

Экономист Уильям Баумоль ещё в 1960-е объяснил «болезнь издержек» сфер услуг: квартет можно сыграть быстрее, но квартет за 20 минут вместо 40 — это уже не тот квартет. Уход — как квартет: его нельзя «ускорить», не обесценив. Поэтому цена ухода везде растёт вместе с зарплатами и везде давит на бюджеты.

**£23,56**

средняя цена часа  
домашнего ухода в  
Англии, 2024/25

**£1 185,55**

средняя цена недели в  
доме ухода  
(residential/nursing),  
Англия, 2024/25 — рост  
+7% за год

**€2 977**

средняя доплата из  
кармана за первый год в  
немецком доме ухода, в  
месяц (начало 2025)

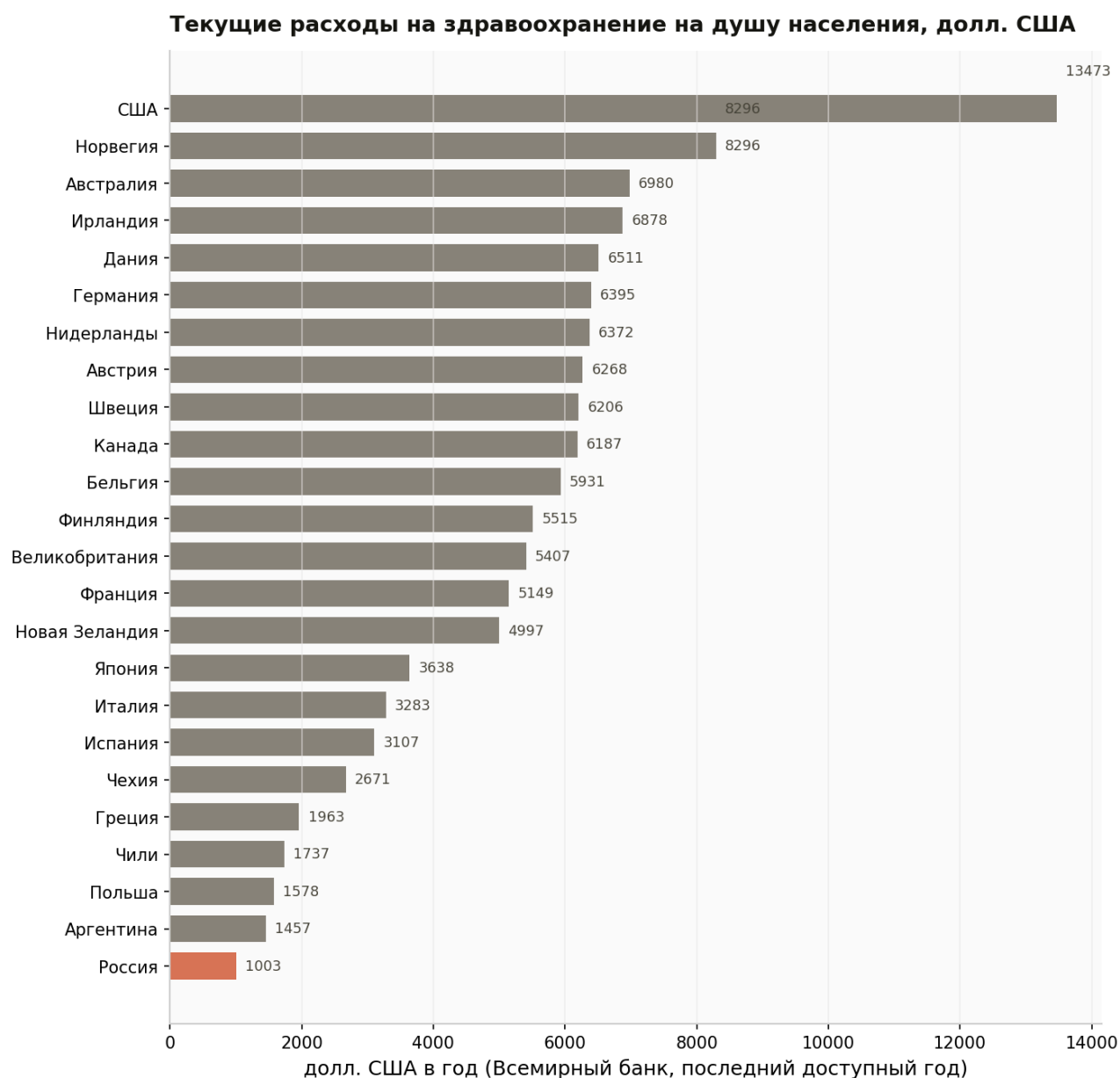
**+135%**

рост расходов немецкой  
Pflegeversicherung за 10  
лет — вдвое быстрее  
доходов системы

Вывод для переговоров: когда директор показывает на зарубежные стандарты, он прав в одном — **стандарты имеют цену труда**. Но из той же цифры следует обратное: если в нашем регионе час сопровождения стоит в десять раз дешевле британского, то на равный бюджет мы можем купить в десять раз больше часов. Не мест. Не коек. **Часов**. Это и есть конкурентное преимущество российской реформы — о нём вся часть 6.

## 2.4. Где Россия на этой лестнице

Посмотрим на более широкую лестницу — расходы на здравоохранение на душу населения по 48 странам (данные Всемирного банка). Это верхняя граница ресурса, из которого финансируется и уход.



**Рисунок 2.2.** Расходы на здравоохранение на душу населения, долл. США (Всемирный банк)

Россия — в нижней трети развитого мира по ресурсу на человека. Наша авторская оценка доли расходов на социальное обслуживание (стационарное плюс домашнее) — **0,1–0,2% ВВП** (методика — приложение В). Это первый этаж лестницы. Но у первого этажа есть своя стратегия — и она доказана Кореей: за 13 лет Корея прошла от 0,1% до 1% ВВП и построила национальную систему с нуля (рисунок 7.1, часть 7). Ступени можно перепрыгивать.

## 2.5. Арифметика для министра: честный ответ на «хотим как в Германии»

Разберём самый частый запрос на числах. «Уход как в Германии» в 2024 году — это:

- €63,3 млрд расходов страхования ухода — **в полтора раза больше, чем пять лет назад**;
- 5,6 млн получателей услуг — каждый пятнадцатый житель страны;
- в среднем €11 300 в год на получателя (амбулантно — €9 172, стационарно — €26 978);
- тарифные зарплаты персонала, закреплённые законом: с 2022 года договор с кассой могут иметь только дома, платящие по тарифу;
- и даже при этом — дефицит, растаявшие резервы и доплата жителей ~€3 000 в месяц за дом.

**Вопрос директора — Почему мы не можем обеспечить уход, как в Германии?**

Потому что «немецкий уход» — это не планировка коридоров, а €11 300 в год на человека и 30 лет страховых взносов. Но мы можем обеспечить **немецкую логику распределения**: лёгким — часы и Pflegegeld (деньги семье), средним — сопровождаемое жильё, тяжёлым — малые дома. Эта логика не требует немецких денег — только честного обследования потребностей и решимости перераспределить существующий бюджет от мест к часам.

**Вопрос директора — Почему мы не можем платить, как раньше?**

Потому что «как раньше» — это цена хранения: 8–24 тыс ₽ в месяц на человека в ПНИ при индексе качества жизни 56,9 балла. Сопровождаемое проживание стоит 2–6 тыс ₽ в месяц при качестве жизни 76,9 балла (оценки НИУ ВШЭ). Продолжать платить «как раньше» — значит переплачивать за худший результат. Реформа не требует больше денег с первого дня; она требует другой архитектуры тех же денег.

*Требовать уход как в Германии, платя как вчера, невозможно. Но перестроить распределение услуг по-немецки на российские деньги — возможно, и именно это делают передовые российские регионы.*

# Передовые модели: что куплено за эти деньги

Восемь моделей из шести стран. Каждая — с ценой, результатом и обратной стороной. Ни одна не идеальна; все — реальны. Читайте их как меню: что из этого вам по карману уже сейчас?

НИДЕРЛАНДЫ · ЭТАЖ 3 · 3,9% ВВП

## 3.1. Деревня Хохевейк и самая дорогая забота мира

**€19,3 млн**

стоимость строительства деревни (2009); €17,8 млн дало государство

**≈€5 000**

в месяц на жителя — как в обычном нидерландском доме ухода

**6–7**

жителей в каждом из 23 домов

**250**

сотрудников на 152 жителя

**Суть модели.** Хохевейк (Weesp, под Амстердамом) — деревня для людей с тяжёлой деменцией, открытая в 2009 году. В ней есть площадь, супермаркет, парикмахерская, театр, паб и кафе — и 23 дома. Каждый дом оформлен в одном из семи «стилей жизни»: городской, аристократический, ремесленный, домашний, культурный, христианский, «индийский» (для выходцев из Индонезии). Люди подбираются в дом по жизненному укладу, а не по диагнозу. Персонал носит обычную одежду: в ремесленном доме сотрудница — «соседка», в аристократическом — «прислуга». Жители сами ходят в магазин, помогают готовить, живут обычной жизнью — под незаметным присмотром.

**Сколько стоит.** Около €5 000 в месяц на жителя — столько же, сколько обычный дом ухода в Нидерландах. Это ключевой факт: «самая прогрессивная модель мира» не дороже традиционной, она просто иначе устроена. Половина мировой прессы ошиблась: чудо Хохевейк не в деньгах, а в проектировании нормальности. Часть расходов закрывают открытые для города кафе и театр.

**Что получилось.** Жители активнее и получают меньше лекарств, чем в традиционных домах. Модель изучают и копируют по всему миру — но копируют чаще «декорации», а не суть: подбор по укладу жизни и обученный персонал-«сосед».

**Оборотная сторона.** Нидерланды — самый дорогой уход мира: 3,9% ВВП, около 80% которого уходит на учреждения. В 2015 году страна провела болезненную реформу: финансирование ухода передали от центра муниципалитетам, урезали пакет и сориентировали систему на домашний уход — расходы на стационар упали на 8% за год. Даже чемпион мира считает деньги и двигается к дому.

### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

Три бесплатных приёма Хохевейк: (1) **малые дома по укладу жизни** — 6–8 человек со схожей биографией, а не 100 по диагнозу; (2) **персонал без белых халатов** и в роли «соседа»; (3) **нормальная жизнь как терапия** — магазин, кухня, двор вместо коридора. Для ПНИ это значит: перепрофилировать корпуса в «дома», разделить проживающих по биографиям, а не по отделениям — и уже это изменит атмосферу без копейки инвестиций. Строительство «деревни» — опционально.

### 3.2. Pflegeversicherung: уход как пятая страховка

В 1995 году Германия сделала то, чего до неё не делал никто: признала зависимость от ухода отдельным жизненным риском — как болезнь, безработицу или старость, — и ввела для него **отдельное обязательное страхование** (Pflegeversicherung). Взнос платят все работающие; право на услугу не зависит от дохода.

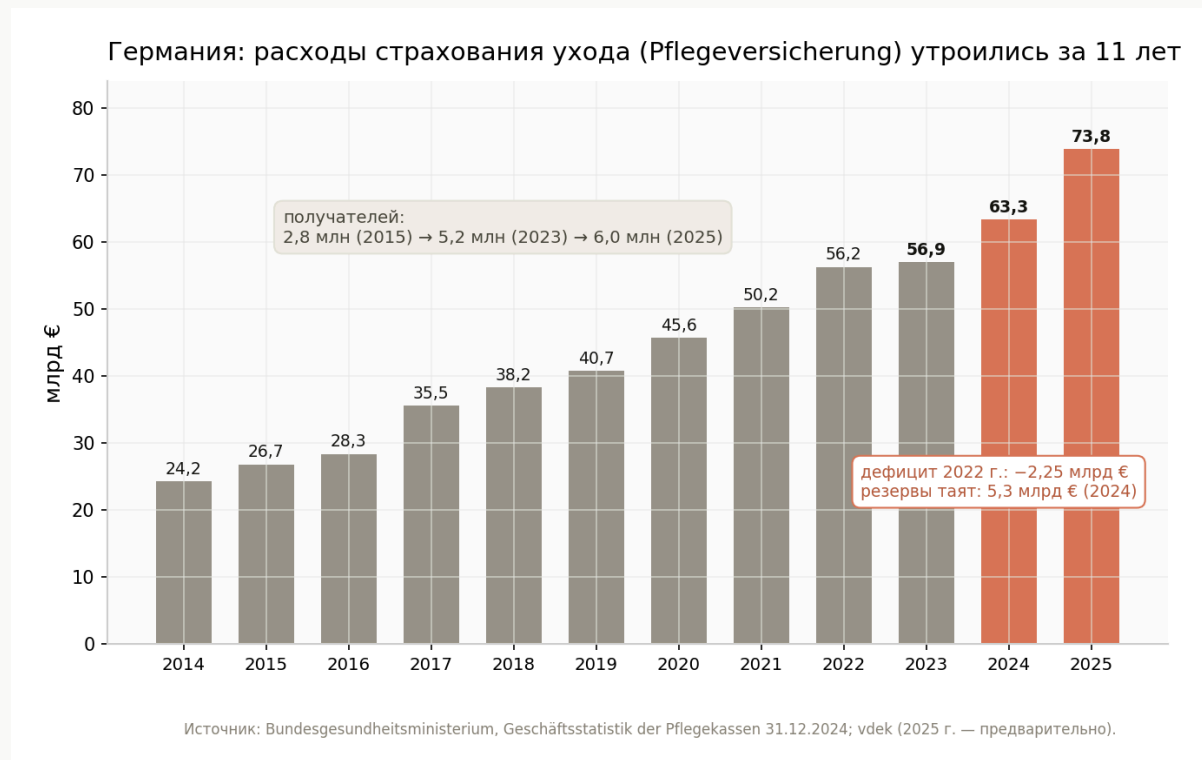


Рисунок 3.1. Расходы социального страхования ухода Германии, млрд € (2014–2025)

**Сколько стоит.** €63,3 млрд в 2024 году (амбулантный уход €41,4 млрд, стационарный €21,8 млрд). Получателей — 5,6 млн человек, их число удвоилось за десять лет после реформы 2017 года, признавшей деменцию основанием для помощи. Средняя цена: амбулантно €9 172/год, стационарно €26 978/год.

**Инженерия спроса.** Немецкая система покупает поведение: денежное пособие Pflegegeld (€18,6 млрд в 2024 году — 27% всех расходов) платят семье, ухаживающей самостоятельно; кому семья не справляется — услуги натурой; кому нужен дом — стационар. Результат: **86% ухода происходит дома**, а стационар растёт всего на 1% в год при росте амбуланта на 7,5%.

**Оборотная сторона.** Система хронически дефицитна: расходы за 10 лет выросли на 135%, доходы — на 117%; резервы таят (€5,3 млрд на конец 2024 года). Страховка не покрывает «гостиничные» расходы дома: житель доплачивает в среднем ~€2 977 в месяц в первый год — и эта сумма растёт.

Германия честно признаёт: универсальное страхование ухода — это путь богатой страны с высокими взносами.

### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

Не страховку (её цена нам пока не по этажу), а три принципа: (1) **уход** — **отдельный бюджетный риск**, который виден и считается, а не размазан по статьям; (2) **деньги за человеком**: пять ступеней потребности (Pflegegrade) → пять пакетов помощи, от пособия семье до дома; (3) **семья** — **партнёр, которому платят**, а не бесплатная рабсила. Российский аналог Pflegegeld на уровне региона — пособие/субсидия семье, забравшей подопечного из ПНИ, — стоил бы копейки от цены места.

ЯПОНИЯ · ЭТАЖ 2 · ≈ 2% ВВП

### 3.3. LTCI: страхование ухода в самой старой стране мира

Япония ввела национальное страхование ухода (LTCI) в 2000 году — в ответ на «социальную госпитализацию»: пожилые годами жили в больницах, потому что идти им было некуда. Принцип LTCI: страхователь — муниципалитет, половина финансирования — взносы граждан 40+, половина — государство; размер помощи определяет сертификация, а план составляет кейс-менеджер.



Источники: MHLW; RIETI (2013); nippon.com по данным MHLW (фиск. 2022: ¥11,2 трлн с учётом профилактики и доплат). Линия — сертифицированные получатели услуг, млн чел. Прогноз MHLW на 2025 г.: ¥19–24 трлн (3,2–4,1% ВВП).

Рисунок 3.2. Расходы LTCI и число получателей услуг (2000–2022)

**Сколько стоит.** ¥11,2 трлн в 2022 финансовом году (с учётом профилактики и доплат). Получателей — 5,6 млн сертифицированных плюс 1,2 млн на профилактических программах. Самые массовые услуги: поддержка ухода на дому (3,9 млн пользователей), прокат оборудования (2,8 млн), дневной уход (1,6 млн). Прогноз MHLW: к 2025 году — ¥19–24 трлн (3,2–4,1% ВВП). Япония платит за то, что решила уход «по-взрослому», — и открыто дискутирует цену.

**Урок из психиатрии.** Похожую операцию Япония провела и с психиатрическими койками: средняя длительность госпитализации сократилась с рекордных ~500 дней (1990-е) до 266 дней — через дневные стационары, визиты на дом и выплату пособий за реинтеграцию. Доказано: длинная койка — не медицинская необходимость, а институциональная привычка.

**Оборотная сторона.** Расходы удвоились за первые 11 лет и продолжают расти; система держится на взносах работающего поколения в самой старой стране мира. Кейс-менеджмент критикуют за бюрократизацию. Япония показывает: даже идеальная инженерия не отменяет демографического счёта.

#### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

(1) **Кейс-менеджер как профессия:** один человек, который собирает для подопечного пакет из разных услуг — именно этого не хватает российским ПНИ при выпуске «в жизнь». (2) **Сертификация потребности** вместо диагноза как основание для объёма помощи. (3) **Дневной уход и прокат оборудования** — самые массовые и самые дешёвые японские услуги; в России их рынок почти пуст, а спрос огромен.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ · ЭТАЖ 2 · ≈2,2% ВВП

### 3.4. Сопровождаемое проживание и персональные бюджеты

Англия — единственная крупная страна, где экономика сопровождаемого проживания посчитана до фунта. Взрослое соцобслуживание здесь — обязанность муниципалитетов: £34,5 млрд расходов в 2024/25 году (+8% за год), из них £23,6 млрд — долговременный уход.

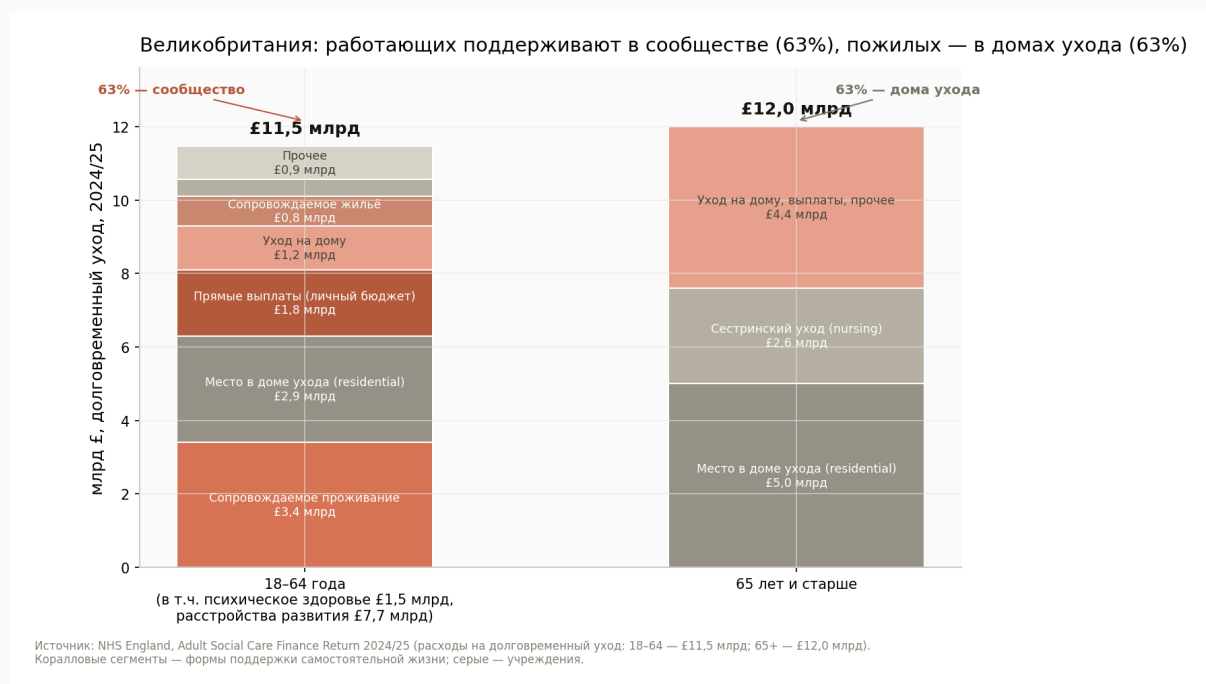


Рисунок 3.3. Структура расходов на долговременный уход в Англии, 2024/25

**Главная находка.** Для людей 18–64 лет (включая психическое здоровье — £1,5 млрд, расстройства развития — £7,7 млрд) почти две трети денег уходят в **сообщество**: сопровождаемое проживание (£3,4 млрд — самая крупная статья!), прямые выплаты (£1,8 млрд), уход на дому (£1,2 млрд). Для 65+ — зеркально: две трети в дома ухода. Система уже перестроилась для работающего возраста: место — исключение, поддержка — правило.

**Цены для переговоров.** Сопровождаемое жильё со съёмным пакетом помощи (SSH): £1 569/неделю (£232 жильё + £1 337 помощь). Место в доме ухода: £1 760/неделю. Лечебное отделение для людей с расстройствами развития (ATU): £3 500/неделю в среднем, пакеты до £10 000. Перевод человека из дома ухода в сопровождаемое жильё даёт совету графства экономию ~£185/неделю на человека — при росте качества жизни.

**Персональные бюджеты и прямые выплаты.** £1,8 млрд в год муниципалитеты платят напрямую людям: получатель сам нанимает ассистентов. Это «Pflegegeld по-английски», но строже: деньги целевые, с договором поддержки.

**Инновационное финансирование.** Golden Lane Housing привлекла £21 млн социальными инвестиционными облигациями (2013/14), купила и адаптировала 62 объекта недвижимости для 205 человек с расстройствами развития. Инвесторам вернули деньги из экономии бюджета.

**Оборотная сторона.** Система хронически недофинансирована: Health Foundation оценивает потребность в +£8,3 млрд к 2032/33; люди доплачивают из кармана £4,7 млрд в год; национальная реформа софинансирования отменена

в 2025 году. Великобритания — пример того, что даже богатая страна не решает уход «одним законом».

#### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

(1) **Считать сопровождаемое проживание отдельной статьёй** — как £3,4 млрд у англичан; то, что не считается, не масштабируется. (2) **Прямые выплаты получателю** — механизм, который может работать и в российском праве через социальный контракт. (3) **Социальные облигации** — уже опробованы в России (Челябинская область, ВЭБ.РФ — см. часть 5.4).

#### ИТАЛИЯ · ЭТАЖ 2 · РЕФОРМА 1978 ГОДА

### 3.5. Триест: город без психиатрической больницы

Италия — единственная страна, закрывшая **все** государственные психиатрические больницы. Закон 180 («закон Базальи», 1978) запретил новые госпитализации в монстров-азили; к 1999 году последняя закрылась. ВОЗ называет систему Триеста одной из самых прогрессивных в мире и четыре десятилетия держит там свой сотрудничающий центр.

**1 : 80 000**

центр психического  
здоровья на население  
— работает 24/7

**1 : 10 000**

психиатрическая  
койка (при обычной  
больнице) на  
население — самая  
низкая норма Европы

**19 000**

мест в малых  
защищённых  
резиденциях —  
больше, чем в любой  
стране Европы

**4 500+**

социальных  
кооперативов, где 30%  
работников — люди с  
инвалидностью

**Суть модели.** Вместо больницы — сеть: круглосуточные центры психического здоровья с несколькими кроватями для кризисов, маленькие дома на 6–8 человек, социальные кооперативы для работы, поддержка жилья. Человек — в центре, а не болезнь: у каждого «жизненный проект», составленный вместе с командой. Принудительные госпитализации — самые редкие в Европе.

**Что НЕ случилось.** Критики закона 180 предсказывали взрыв суицидов, бездомности и заполнение тюрем. Ничего из этого не произошло — ни в Триесте, ни в Италии в целом. Оценки показывают и экономическую эффективность: круглосуточный центр с малым числом коек дешевле больницы при лучшем результате.

**Оборотная сторона.** Закон 180 — национальный, а исполнение — региональное. Триест и Фриули-Венеция-Джулия построили полную модель; ряд южных регионов — лишь витрину: центры, открытые 8 часов в день, без

круглосуточной помощи и жилья. Урок: **реформа выигрывает там, где дожата до локальной инфраструктуры.**

### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

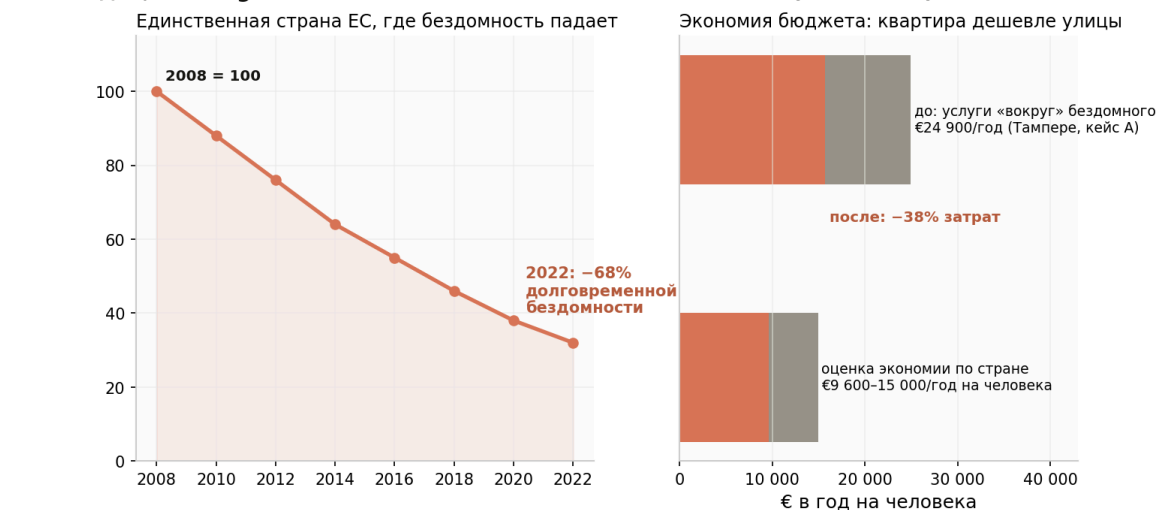
(1) **Социальный кооператив** — рабочее место для подопечных внутри нормальной экономики (пекарня, прачечная, мастерская); российский пробный камень — Усадьба Аристовых в Свердловской области (дом на 7 человек + пекарня). (2) **Жильё как часть «рецепта»**: в Триесте поддержка начинается с адреса. (3) **Кризисная кровать в центре, а не отдельная больница** — снимает страх «а что, если обострение».

### ФИНЛЯНДИЯ · ЭТАЖ 3 · HOUSING FIRST

## 3.6. Housing First: сначала квартира, потом всё остальное

Финляндия — единственная страна ЕС, где бездомность сокращается. Секрет — переворот логики: раньше жильё было «наградой» за лечение и трезвость; Housing First даёт **сначала постоянную квартиру с договором**, а помощь прикладывает уже к адресу. Трезвость — не условие.

### Финляндия, Housing First: сначала жильё — потом всё остальное (2008–2022)



Источники: ARA/Pathfinders (2024); OECD Ecoscope (2021); Министерство окружающей среды Финляндии (2011); экономия €14 980/год на человека в пилоте на 15 человек; 4 600 квартир за 10 лет; приюты Хельсинки переоборудованы в жильё.

Рисунок 3.4. Housing First: долговременная бездомность и экономия бюджета

**Сколько стоит и сколько экономит.** Оценки: €9 600–15 000 экономии в год на каждом бывшем бездомном — за счёт скорой помощи, полиции, тюрем и ночлежек. В пилоте Министерства окружающей среды (15 человек) экономия составила €14 980 на человека в год. В Тампере посчитали честно, по двум домам: в одном — экономия 38% (жители пришли с улицы, где

«обслуживались» дорого), во втором — рост затрат (люди пришли из дешёвых ночлежек и получили полноценную поддержку). Вывод финнов зрелый: **экономия зависит от того, с чего человек стартовал, но качество жизни растёт всегда.**

**Что получилось.** Долговременная бездомность —68% за 2008–2022 годы; 4 600 квартир за 10 лет; приюты Хельсинки переоборудованы в обычные жилые дома с поддержкой; в городе осталось одно ночное убежище на 52 места. 80% попавших в программу сохраняют жильё.

**Оборотная сторона.** Программа требует реальных квартир: если жилфонд жёсткий, субсидия аренды раздувает цены. Молодёжь и мигранты вписываются в модель хуже, чем «классические» хронические бездомные. И «устранить бездомность к 2027 году» — это годы политической воли четырёх правительств подряд.

#### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

Housing First для ПНИ — это и есть сопровождаемое проживание: **не «заслужи квартиру дисциплиной», а «получи квартиру и сопровождение сразу».** Финский расчёт экономии — готовый шаблон для регионального Минфина: посчитайте, во что обходится человек «внутри» (место, койки, экстренные службы), и сравните с ценой квартиры плюс 12 часов в неделю. Челябинский пилот (16 человек перешли на самостоятельное проживание) — тот же принцип.

ДАНИЯ · ЭТАЖ 3 · ≈3,5% ВВП

### 3.7. Закон 1987 года и жильцы-наниматели с полной пенсией

Дания сделала в 1987 году то, о чём в России только говорят: **запретила строить традиционные дома ухода.** Закон о жилье для пожилых и инвалидов разрешил только «plejeboliger» — дома из отдельных квартир: своя кухня, своя ванная, два окна, дверной звонок и почтовый ящик. Признаки самостоятельного жилища закреплены законом.

**Ключевая норма для России.** Жилец plejebolig — **наниматель квартиры.** Он получает полную пенсию, платит аренду и сам решает, покупать ли у дома уборку, обеды и стирку. До реформы жилец получал «карманные деньги», а пенсия уходила учреждению — **ровно как российские 75%.** Дания отменила это почти 40 лет назад — и ничего не рухнуло: у человека появились деньги, выбор и статус, а у дома — стимул быть услугой, а не хранилищем.

**Reablement: тренировка вместо обслуживания.** С 2015 года в законе закреплён подход «hverdagsrehabilitering»: вместо пассивной помощи — интенсивная 3–12-недельная тренировка бытовых навыков междисциплинарной командой. Цель — не «обслужить», а вернуть самостоятельность. Многие после курса вместо постоянной помощи получают эпизодическую.

**Оборотная сторона (важно!).** Дания — чемпион деинституционализации, но и у неё есть обратная сторона: домашняя помощь ужалась по часам — «символическая уборка» 15 минут раз в три недели вместо нормальной; охват 80+ домашним уходом упал с 43% (2008) до 27% (2020); каждый четвёртый работник ухода — без профильного образования. Экономия «вытеснения вниз» реальна. Подробнее — часть 4.4.

#### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

(1) **Юридический статус жильца:** перевести проживающих ПНИ из «казённых» в «нанимателей» с полной пенсией — сначала в пилотных корпусах. Это вопрос закона, а не денег. (2) **Запрет новых «казарменных» корпусов** как норма: строить и реновировать только малыми квартирами. (3) **Reablement:** тренировочные квартиры Свердловской и Тюменской областей — это и есть русский reablement; ему нужна методика и стандарт, а не бюджет.

БРАЗИЛИЯ · ЭТАЖ 1 → 2 · СТРАНА С УРОВНЕМ ДОХОДА, БЛИЗКИМ К РОССИЙСКОМУ

### 3.8. Деньги, которые пошли за человеком

Бразилия — самый ценный кейс для России, потому что она делала реформу в наших бюджетных координатах. Закон 10.216 (2001) запустил закрытие психиатрических больниц и развитие общинных служб (CAPS). Результат за два десятилетия:

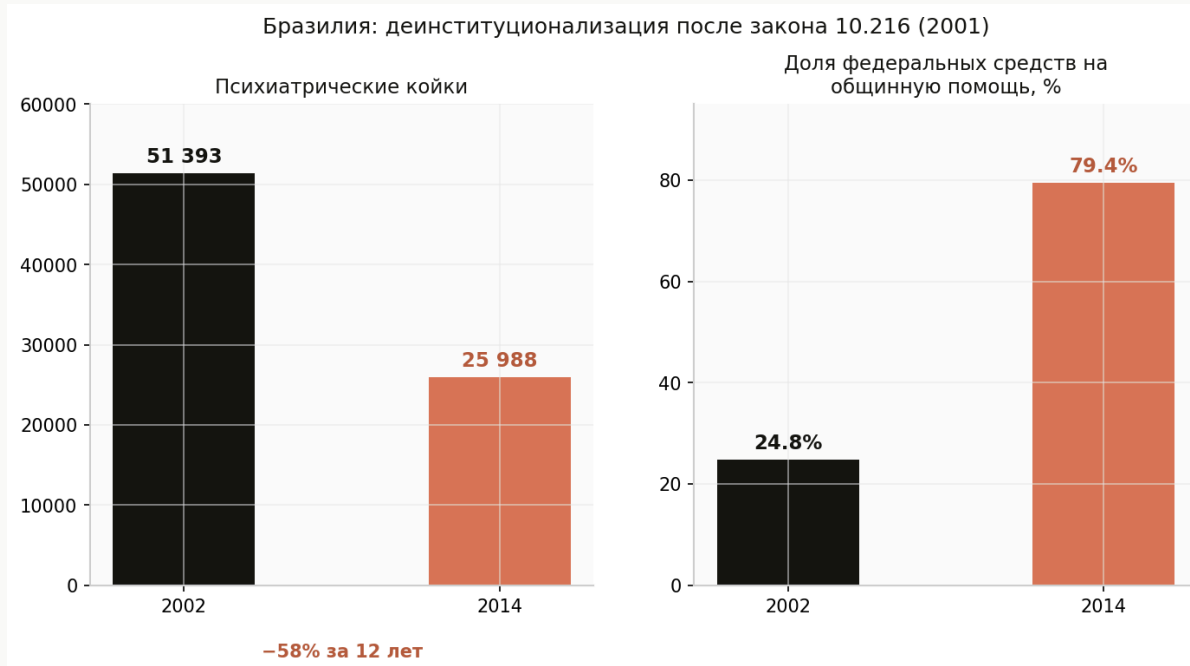


Рисунок 3.5. Бразилия: койки и структура финансирования

**Три механики бразильской реформы.** (1) **Койки –58%** — закрывались поэтапно, под созданные службы. (2) **Доля общинного финансирования выросла с 24,8% до 79,4%** — деньги физически перенаправили из больничного раздела бюджета в общинный; это решение Минздрава, а не новые деньги. (3) **«Volta para Casa» — «Возвращение домой»:** человеку, вышедшему после многих лет в больнице, платят реабилитационное пособие R\$709,25 в месяц (порядка четверти минимальной зарплаты) — дёшево, а символически бесценно: государство финансирует возвращение, а не хранение.

**Оборотная сторона.** Реформа неравномерна: бедные северо-восточные штаты отстают, частные «психиатрические коммерческие» формы местами воспроизвели старые пороки; стигма в обществе сильна. Но направление и механика доказаны именно в условиях ограниченных денег.

#### ЧТО ВЗЯТЬ РОССИИ

Бразилия доказала главное: **перенаправление бюджета возможно без его увеличения.** Пособие «возвращения домой» — прямо применимая идея: выходящему из ПНИ в сопровождаемое проживание — ежемесячная реабилитационная выплата первые 12–24 месяца. При цене места 8–24 тыс Р/мес пособие даже в полный размер сопровождения (2–6 тыс Р) уже выгодно бюджету — и это не считая эффекта для человека.

# Дорогие ошибки: негативный опыт, который экономит нам миллиарды

Пять историй о том, как не надо. Они важнее положительных примеров: чужие провалы — единственные, за которые не надо платить своими людьми. У каждой истории есть ценник.

США · 1963–НАШИ ДНИ · ЦЕНА ОШИБКИ: \$31 000/ГОД НА ЧЕЛОВЕКА

## 4.1. Деинституционализация без сообщества привела в тюрьму

Америка закрыла государственные психиатрические больницы быстрее всех в мире — и без строительства общинной инфраструктуры. «Community Mental Health Act» 1963 года обещал 1 500 центров; построено было меньше половины, а финансирование обрезали уже в 1980-е. Люди вышли из палат — на улицу. Дальше — конвейер: улица → арест за мелкое нарушение → тюрьма → улица.

**383 000**

людей с тяжёлыми психическими расстройствами за решёткой (2014)

**× 10**

больше, чем в оставшихся госпиталях

**\$650 млн**

в год тратит один Техас на содержание 12–16 тысяч людей с психическими расстройствами в тюрьмах

**\$31 000 vs \$10 000**

год в тюрьме против года помощи в сообществе

**Механика провала.** Койку закрыть легко и приятно — это «экономия». Сообщество строить долго и незаметно. Пока второе откладывали, первое уже случилось. Вакуум заполнила единственная круглосуточная институция, которая не может отказать, — тюрьма. Суицид — ведущая причина смерти в американских следственных изоляторах; за решёткой людям становится хуже, рецидивизм выше, сроки длиннее.

### УРОК ДЛЯ РОССИИ

Деинституционализация — это не закрытие корпусов, а **замещение функций**. Правило американской катастрофы: сначала альтернатива, потом выселение. Каждое место в ПНИ можно сокращать только под созданную квартиру/часы. Иначе вакуум заполнят полиция, скорая и больничная койка — втрое дороже.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ · 2011–2021 · ЦЕНА ОШИБКИ: £3 500/НЕДЕЛЮ ЗА НАСИЛИЕ

## 4.2. Уинтербоурн-Вью: почему деньги и законы не сработали десять лет

31 мая 2011 года программа BBC Panorama показала скрытую съёмку из частной «больницы» Уинтербоурн-Вью: персонал издевается над людьми с расстройствами развития и аутизмом. За содержание каждого человека NHS платила оператору Castlebeck до **£3 500 в неделю**. Одиннадцать сотрудников осуждены почти по 40 эпизодам. Регулятор CQC получал сигналы с 2008 года — и не реагировал; комиссия по защите прав получила 40 сигналов — и не действовала; пациенты жаловались семьям — им не верили.

Правительство ответило программой «Therapeutic Community Care»: закрыть «оценочно-лечебные отделения», вернуть людей домой, нарастить поддержку. Через десять лет, в 2021 году, парламент обсуждал те же кейсы: юная Бетани заперта в изоляторе, потому что муниципалитету

«нужен перерыв от оплаты её поддержки»; Райан не выписывается три года после решения о выписке. Парламентарий резюмировал: насильственный уход стоил государству £3 500 в неделю — «намного больше, чем те пара дополнительных часов поддержки, которые были нужны ему дома».

**Механика провала.** Не хватило не денег и не законов — их было достаточно. Не хватило **локальной инфраструктуры и ответственности**: некуда выписывать (нет жилья и команд), некому отвечать за сроки, и нет внешних глаз внутри закрытых учреждений. Скандал вскрыл и отраслевую ловушку: «отправить подальше» удобно и муниципалитету, и оператору — выгодно всем, кроме человека.

#### УРОК ДЛЯ РОССИИ

(1) Закрытое учреждение без внешних глаз рано или поздно становится Уинтербоурн-Вью: независимые визиты, семейный доступ, публичная отчётность — самая дешёвая защита. (2) «Выписать» невозможно без «выписать КУДА»: сначала жильё и команда, потом решение. (3) Дорогое плохое место существует потому, что дешёвого хорошего нет; рынок малых форм нужно строить заранее.

ГРЕЦИЯ · 1984–1995 · ЦЕНА ОШИБКИ: 1,4 МЛРД ДРАХМ ВПУСТΟΥ

### 4.3. Лерос: как потратить деньги Европы и не изменить ничего

Остров Лерос — «Европейская грязная тайна» (заголовок Observer, 10 сентября 1989 года): 1 200 человек в бывших казармах, голые люди, привязанные к кроватям и деревьям, ни один не имел связи с семьёй, за 40 лет никому не сделали даже удостоверений личности. Европейская комиссия выделила деньги на реформу ещё в 1984 году. К 1989-му освоено было около 20% — и единственным изменением стала сортировка людей по диагнозам в те же корпуса.

**Первая попытка (провал).** После скандала греческие психиатры-НКО получили **1,4 млрд драхм** и организовали 13 пансионатов по 9–10 мест — по принципу «землячества». Работники приезжали на пару месяцев, выбирали самых тихих и самостоятельных — и увозили около сотни человек из 1 100. Тысяча осталась. Деньги были потрачены, отчёты сданы, «ноу-хау» не осталось.

**Вторая попытка (успех).** Команда Триеста (ученики Базальи) попросилась на остров и получила втрое меньше — 465 млн драхм — на самые тяжёлые корпуса 11 и 16: 460 человек. Пять лет работы: личные истории, 400+ удостоверений личности, малые дома, труд, обучение местного персонала,

работа с экономикой острова (он жил за счёт «больницы» и боялся её закрытия). Через 3–4 года после ухода итальянцев: 92,6% бывших жителей довольны условиями жизни — но 62,1% так и не обрели семью, и только 31,6% работали: сорок лет хранения не лечатся за пять лет.

#### УРОК ДЛЯ РОССИИ

(1) **Деньги без модели = сортировка по диагнозам.** Разница между первой и второй попыткой — не сумма, а присутствие команды с методом, которая живёт проблемой годами. (2) **Кремлёв... то есть «островной» эффект:** если экономика территории держится на интернате, закрытие будет саботироваться — нужен план для сотрудников и муниципалитета, а не только для жителей. (3) Чем дольше хранение, тем дороже выход: реабилитация после 40 лет длится поколение. Начинать надо с молодых и «лёгких» — эффект быстрее и дешевле.

СКАНДИНАВИЯ · 2000–2020 · ЦЕНА ОШИБКИ: ОЧЕРЕДЬ И «СИМВОЛИЧЕСКАЯ УБОРКА»

#### 4.4. Обратная сторона успеха: таргетирование до нуля

Скандинавские страны — мировые чемпионы деинституционализации. Но у медали есть оборот, о котором они пишут сами. Швеция: каждая четвертая койка учреждений исчезла за 2000–2015 годы; доступность места для 80+ упала с 20% до 11%; очередь выросла до 64 дней, и половина муниципалитетов прямо называет причину — нехватка ресурсов. Дания: охват домашней помощью среди 80+ упал с 43% до 27%; уборка сокращена до 15 минут раз в три недели — «символическая». Норвегия: разброс охвата между муниципалитетами — от 32% до 76% при одинаковой потребности.

**Механика провала.** Деинституционализация совпала с бюджетным сжатием. Муниципалитеты сделали рациональное и страшное: помощь оставили только самым тяжёлым, а «нижние ступени» (профилактика, быт, одиночество) лишились ресурса. Результат — «лестница ухода» (omsorgstrapp) с выбитыми ступенями: человек не получает дешёвой помощи сегодня — и приходит в дорогое учреждение через год. Экономия обернулась перерасходом и неравенством.

### УРОК ДЛЯ РОССИИ

Двигая людей из интернатов в сообщество, **нельзя урезать «лёгкие» услуги** — дневную занятость, социальное сопровождение семьи, профилактические визиты. Именно они удерживают человека вне учреждения. Экономия на «нижних ступенях» — самая дорогая экономия: Скандинавия переплачивает за это очередями и возвратами в учреждения.

ГРЕЦИЯ · 2009 · ЦЕНА ОШИБКИ: РЕФОРМА ОТКАТИЛАСЬ

### 4.5. Реформа без устойчивого финансирования откатывается

Через двадцать лет после Лероса ВВС вернулась в греческую психиатрию — и нашла в больнице Дромокраитион привязанных к кроватям пациентов, двух медсестр на 30 человек (вдвое меньше минимума) и прямое признание персонала: «у нас просто нет ресурсов ухаживать иначе». Еврокомиссар по социальным делам констатировал: прогресс «замедлился и начал разворачиваться». При этом в той же стране работал пансионат «Афина»: 25 сотрудников на 15 жителей и принципиальный отказ от фиксации — разговор вместо ремней.

**Механика провала.** Реформа Греции финансировалась проектами ЕС — деньги кончились, команды распались, приоритеты сместились, и система сжалась обратно в привычную форму: дефицит персонала → фиксация. Разница между «Афиной» и Дромокраитионом — не в законах (они общие), а в **норме обеспеченности**: уход держится на людях, а люди — на бюджете.

### УРОК ДЛЯ РОССИИ

Пилоты, построенные на временных грантах, откатятся после финального отчёта. Каждая инициатива из части 5 должна иметь ответ на вопрос: **какая постоянная статья бюджета подхватит её в третий год?** Второй вывод: нормы численности персонала — не бюрократия, а главная гарантия от «ремней». Две медсестры на 30 — это и есть будущее насилие.

## 4.6. Синтез: пять правил провала и пять правил успеха

### Как провалить реформу

- **Сначала закрыть, потом построить** — вакуум заполнит тюрьма или койка (США).
- **Выдать деньги без модели и команды** — получится сортировка по диагнозам (Лерос-1984).
- **Закрывать глаза и двери** — закрытое учреждение без внешнего контроля деградирует (Уинтербоурн-Вью).
- **Срезать «нижние ступени»** — дешёвая профилактика, без неё люди возвращаются в дорогие учреждения (Скандинавия).
- **Построить реформу на временных деньгах** — после гранта система сожмётся обратно (Греция-2009).

### Как сделать реформу рабочей

- **Сначала альтернатива, потом выселение** — квартира и команда раньше решения о переводе (Финляндия, Триест).
- **Деньги за человеком** — перенаправление бюджета из мест в часы и жильё (Бразилия: 24,8% → 79,4%).
- **Открытость как система безопасности** — семьи, независимые визиты, публичные метрики (урок Великобритании).
- **Сохранить «лёгкие» услуги** — занятость, сопровождение, тренировка навыков (Дания: reablement).
- **Постоянная статья бюджета** — каждый пилот должен знать, кто его кормит в третий год (урок Греции).

# Россия: что уже происходит и сколько это стоит

## 5.1. Экономика ПНИ сегодня

Сколько стоит месяц жизни человека в российской системе? Честных измерений немного, но они согласованы между собой. Оценка НИУ ВШЭ: содержание в государственном ПНИ обходится в **8–24 тысячи ₽ в месяц** на человека (разброс — регионы и уровень обеспеченности). Частный ПНИ в Подмоскowie: 1 100–1 700 ₽ в сутки, то есть **33–51 тысяча ₽ в месяц**. Психиатрическая больница по прейскурантам регионов: койко-день 1 100–4 840 ₽ — **33–145 тысяч ₽ в месяц**. И на другом конце шкалы — сопровождаемое проживание: **2–6 тысяч ₽ в месяц** поддержки на человека (оценка НИУ ВШЭ).

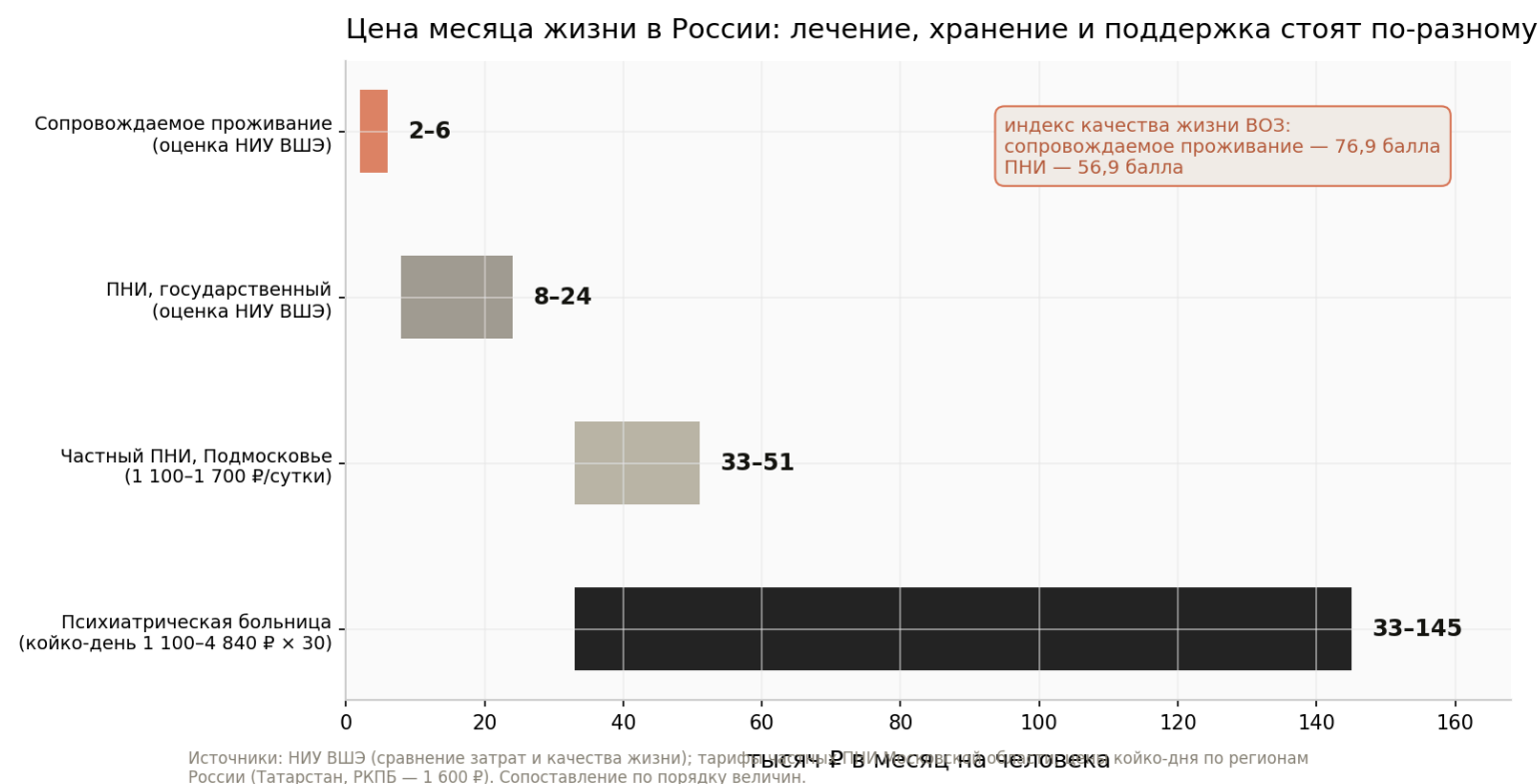


Рисунок 5.1. Цена месяца жизни в четырёх форматах

При этом качество жизни по методологии ВОЗ в сопровождаемом проживании — **76,9 балла против 56,9 в ПНИ**. Система платит больше за худший результат: классический «интернатный парадокс», знакомый нам по части 4. Разница российская лишь в том, что у нас он ещё и дешевле всего исправляется: цены абсолютно малы, поэтому перестройка не требует европейских миллиардов.

Вторая опора экономики ПНИ — пенсия жителя. Государство удерживает **75% пенсии** проживающего в счёт оплаты проживания. Для ПНИ это скрытая субсидия в десятки миллиардов рублей в год масштаба страны; для человека — пожизненная безденежность. Параллельно действует важная реформа 30 октября 2021 года: отменено удержание 75% **заработной платы** работающих жителей интернатов — труд наконец стал приносить человеку деньги, а не учреждению.

## 5.2. 75% пенсии: датский взгляд на российскую норму

### Сравнение, которое стоит процитировать на совещании.

Дания до 1987 года: жилец дома ухода получал «карманные деньги», пенсия уходила учреждению — как в России сегодня. Дания после 1987 года: жилец — наниматель квартиры, получает полную пенсию, платит аренду и сам выбирает платные услуги. Что изменилось для бюджета? Почти ничего: деньги те же, поменялся их маршрут. Что изменилось для человека? Всё: деньги, выбор, статус, стимулы учреждения. Удержание 75% — это не «источник финансирования ПНИ», это запрет на самостоятельность, встроенный в экономику. Возвращение пенсии человеку — самая дешёвая реформа из всех возможных: она не требует новых денег, только нового маршрута существующих.

## 5.3. Правовая рамка: 137-ФЗ и пилот Минтруда

- **Сентябрь 2023 — 137-ФЗ:** понятие «сопровожаемое проживание» закреплено в федеральном законодательстве. До этого регионы действовали «в правовом поле эксперимента», теперь — в законе.
- **С 2019 года** — субсидии в рамках госпрограммы «Доступная среда» на развитие форм сопровождаемого проживания.
- **С 2022 года — пилот Минтруда** в Воронежской и Нижегородской областях (завершение — 2025 год): отработка стандартов сопровождаемого проживания для жителей ПНИ.
- **Практика шире пилота:** элементы сопровождаемого проживания применяют **84 региона**, социальную занятость — **69**, сопровождаемую трудовую деятельность — **67**.
- **Оценка Минтруда:** потенциал перевода из ПНИ в форматы самостоятельной жизни — **до 45% подопечных**.

Это важная рамка для директора: реформа в России — не проект «когда-нибудь», а действующее правовое поле с федеральным пилотом, стандартами и первыми результатами. Вопрос не «начинать ли», а «с какой скоростью идти».

## 5.4. Восемь региональных кейсов

Эти кейсы — не витрина, а строительная площадка. Читайте их с ручкой: у каждого есть механика, которую можно воспроизвести в вашем регионе в этом бюджетном цикле.

## НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ · ПИЛОТ МИНТРУДА · МЕТОД «СНАЧАЛА ОБСЛЕДОВАНИЕ»

## Каждый пятый — 12 часов в неделю

**350**

жителей ПНИ прошли углублённое обследование потребностей

**20%**

нуждаются в сопровождении не более 12 часов в неделю

**11**

человек уже живут в специализированном доме

**2**

получили квартиры как сироты — и вышли из системы интерната совсем

**Механика.** Область начала не со строительства и не с программы, а с обследования: междисциплинарная оценка реальных потребностей жителей ПНИ. Результат опрокинул интуицию: у каждого пятого потребность — до 12 часов сопровождения в неделю, то есть цена двух-трёх рабочих визитов. Под обследованные группы создали спецдом (11 человек), а двоим восстановили право на жильё как сиротам — человек с квартирой перестаёт быть «проживающим ПНИ» вообще.

## КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

Обследование — самый дешёвый и самый убедительный первый шаг: оно превращает абстрактное «недееспособны» в карту конкретных потребностей в часах. Смета — зарплата команды и методика; срок — месяцы; результат — готовый бизнес-кейс для Минфина региона: «вот 20% людей, чьё содержание можно сделать вчетверо дешевле».

## ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ · МАСШТАБ И ДЕНЬГИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

## Мультицентр, 14 дополнительных услуг и субсидия 500 тысяч

**150**

человек — охват Мультицентра социальной интеграции

**14**

дополнительных услуг сверх базового перечня, включая «помощь в управлении финансовыми ресурсами»

**500 тыс ₽**

субсидия работодателю за оборудование рабочего места для человека из ПНИ

**Механика.** Область построила цепочку: мультицентр (сопровождение, обучение, занятость) → расширенный перечень услуг (включая финансовое сопровождение — то, что раньше решала недееспособность «по умолчанию») → прямая субсидия работодателю. Последнее — переворот: государство платит не за «хранение безработного», а за создание ему рабочего места. Дорого? 500 тыс

Р — это два года содержания в ПНИ по нижней границе, после чего человек начинает платить налоги.

#### КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

Субсидия работодателю — готовый инструмент: оформляется региональным постановлением, деньги — из существующих программ занятости. Начать можно с 5–10 рабочих мест. Услуга «помощь в управлении финансами» — ответ на главный барьер (недееспособность): она позволяет не лишать человека прав, а обучать пользоваться ими.

#### СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ · ТРЕНИРОВКА И КООПЕРАТИВ

### Тренировочные квартиры и Усадьба Аристовых

**Механика 1 — reablement по-уральски.** Тренировочная квартира: жители ПНИ живут в ней временно и отрабатывают бытовые навыки — готовка, бюджет, уборка, транспорт — под контролем сопровождающих. Прошёл курс — переходишь в сопровождаемое проживание; не прошёл — возвращаешься без травмы провала. Это датский reablement, собранный на российской базе.

**Механика 2 — дом + работа.** Усадьба Аристовых: дом на 7 человек с пекарней. Жители работают в собственном производстве: малое жильё плюс малая экономика — та самая модель итальянского социального кооператива (Триест, часть 3.5), только уже в России. Дом не потребляет бюджет на «занятость» — он её производит.

#### КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

Тренировочная квартира требует одной квартиры (аренда или муниципальный фонд) и смены статуса: она не «место проживания», а «тренажёр». Пекарня/мастерская при доме — из экономики Усадьбы: начать с продукта, который покупает сам регион (выпечка, пошив, услуги для учреждений).

#### ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ · ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

## Первые в стране деньги ВЭБ.РФ на выход из интерната

16

человек перешли на самостоятельное проживание

8

остались жить в семьях благодаря сопровождению (не попали в ПНИ)

**Механика.** Проект социального воздействия с ВЭБ.РФ и РМК: внебюджетные деньги финансируют программу, а регион платит инвестору из **достигнутой экономии и результатов**. Два десятка человек — немного; но доказана схема: реформу интернатов можно финансировать как инфраструктуру — деньгами развития под измеримый результат, а не только текущей статьёй.

### КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

Механизм проектов социального воздействия (социальные облигации) уже работает в российском праве. Региону нужны три вещи: измеримая метрика (число людей, переведённых в сопровождаемое проживание), посчитанная экономия (разница цены места и поддержки) и оператор. Golden Lane Housing в Англии привлекла так £21 млн — см. часть 3.4.

## ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ · ДОРОЖНАЯ КАРТА И ТЕХНОЛОГИИ

### Дорожная карта 2020–2024 и 3D-квартира

**Механика.** Тюмень — единственный регион, оформивший переход как **дорожную карту** со сроками и ответственными (2020–2024): не разовый проект, а поэтапная перестройка системы. Фирменная технология — 3D-квартира: виртуальное и физическое пространство для обучения бытовым навыкам и IT-компетенциям перед реальным выходом. Охват сопровождаемого проживания рос по плану: 65 → 75 человек.

### КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

Ценность Тюмени — управленческая: дорожная карта с этапами «обследование → тренировка → квартира → сопровождение» превращает благие пожелания в календарь. Это бесплатно — нужно решение главы региона и один ответственный за карту.

## ХМАО — ЮГРА · ВОЗРАСТНОЙ СРЕЗ 18–55

## Излучинский дом-интернат: модельная программа

**Механика.** На базе Излучинского дома-интерната отработана «Модельная программа» сопровождаемого проживания для людей **18–55 лет**: сознательный сдвиг от «дожития» к «взрослой жизни» — работа, жильё, отношения. Югра показывает: сопровождаемое проживание — не гериатрическая тема, а тема людей, которым жить ещё полвека.

### КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

Выделите в ПНИ возрастную когорту 18–55 и посчитайте её отдельно: у неё самый длинный «остаток оплаты» (десятилетия хранения впереди) и самая высокая отдача от перевода в самостоятельную жизнь. Экономически это самая выгодная группа для старта.

## КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ · МАЛЫЙ ДОМ ПРИ ПНИ

### Галишевский ПНИ: отделение на 14 мест

**Механика.** При Галишевском ПНИ создано отделение сопровождаемого проживания на 14 мест, где живут и 5 дееспособных, и 5 недееспособных жителей. Важен прецедент: **недееспособность не является автоматическим запретом** на жизнь вне палатного корпуса — сопровождение подбирается под человека, а не под юридический статус.

### КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

Малый дом «при ПНИ» — самый мягкий старт: не требует ни отдельного здания, ни смены учредителя. Корпус или флигель перепрофилируется в дом на 10–14 мест с квартирной планировкой жизни. Это «Хохевейк в миниатюре» на существующей базе.

## ЯНАО · НОРМАТИВНАЯ БАЗА РЕГИОНА

### Постановление 1064-П: реформа как документ

**Механика.** Ямал одним из первых закрепил сопровождаемое проживание региональным нормативным актом (постановление 1064-П, 2021): порядок, стандарты, финансирование — прописаны. Скучно? Именно так выглядит

масштабируемость: пока практика живёт энтузиазмом директора, она умрёт вместе с его переводом; прописанная — переживёт.

#### КАК ВОСПРОИЗВЕСТИ

У вашего региона есть готовые тексты: возьмите ямальское постановление и пакет Минтруда по пилоту, адаптируйте под свою структуру расходов. Юридическая работа на неделю — и у вас «свой 1064-П».

## 5.5. Разрыв охвата: два порядка между потенциалом и фактом

Соберём цифры в одну картину. Жителей ПНИ — 160–220 тысяч. Потенциал перевода по оценке Минтруда — до 45%: это 70–100 тысяч человек. А в сопровождаемом проживании сегодня — **менее 1 774 человек**, в 214 квартирах постоянного проживания (2024). Лидеры — Санкт-Петербург, Ленинградская и Свердловская области.



Рисунок 5.2. Потенциал реформы и текущий охват

Есть и проблема качества уже созданного: средняя группа в квартирах — **7–8 человек**, то есть выше рекомендаций Минтруда (3–4). Экономика давит: квартира на 8 дешевле квартиры на 4 — но именно малость группы и есть суть модели (вспомним Хохевейк: 6–7, Данию: отдельные квартиры). Здесь важно не наступить на скандинавские грабли из части 4.4: «экономный» вариант съедает смысл.

*Разрыв в два порядка — это не упрёк, а рынок: десятки тысяч людей и миллиарды рублей бюджетной эффективности ждут регионов, которые пойдут первыми.*

## 5.6. Карта барьеров: шесть стен, через которые идти

Таблица 5.1. Шесть барьеров и способы их прохода (по опыту регионов и мира)

| Барьер                              | Суть                                                             | Как проходят                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <b>Недееспособность</b>          | Более 70% жителей ПНИ лишены дееспособности; «нельзя» выписывать | Курган: недееспособные живут в малом доме — статус не запрет. Ленобласть: услуга «помощь в управлении финансами». Долгая дорога — восстановление дееспособности через суд с доказательной базой проживания |
| 2. <b>Жильё</b>                     | У человека нет квартиры — некуда выписывать                      | Нижний Новгород: восстановление сиротских прав (2 квартиры). Муниципальный фонд, аренда с субсидией, соцнайм. Финляндия: строить/выкупать квартиры — иначе субсидия раздувает рынок                        |
| 3. <b>75% пенсии</b>                | Человек без денег не может жить самостоятельно                   | Дания-1987: жилец = наниматель с полной пенсией, платит аренду сам. В России нужна федеральная инициатива; регион может подготовить расчёты и пилот                                                        |
| 4. <b>Финансирование «на место»</b> | Бюджет ПНИ считается по местам; сократил места — потерял деньги  | Бразилия: перенаправление доли бюджета (24,8% → 79,4%). Региональный норматив «на человека с потребностью» вместо «на койку/место»                                                                         |
| 5. <b>Кадры</b>                     | Сопровождающих специалистов нет как профессии                    | Япония: кейс-менеджер — отдельная профессия. Обучение действующих сотрудников ПНИ: они знают людей; нужна методика и тариф                                                                                 |
| 6. <b>Страх ответственности</b>     | «Что, если с человеком что-то случится вне стен?»                | Триест: кризисная кровать в центре, а не больница за городом. Тюмень: тренировочный этап снимает риск до реального выхода. Страхование ответственности через пилотный статус                               |

Обратите внимание: ни один из шести барьеров не называется «нет денег». Деньги — пятый вопрос; первые четыре — право, жильё и организация. Именно поэтому регионы с разными бюджетами двигаются с разной скоростью: решает не казна, а связка «решение главы + ответственный + документ».

# Калькулятор реформы для региона

Эта часть — рабочий инструмент. Здесь мы считаем в рублях: сколько стоит каждая единица услуги, что может регион с любым бюджетом и откуда взять деньги без новых денег.

## 6.1. Цена единицы услуги: час, квартира, место, дом

Сначала — универсальный закон из части 3: во всех странах, где это измеряли, поддержка жизни вне учреждения дешевле хранения внутри него — в 1,6–4 раза.

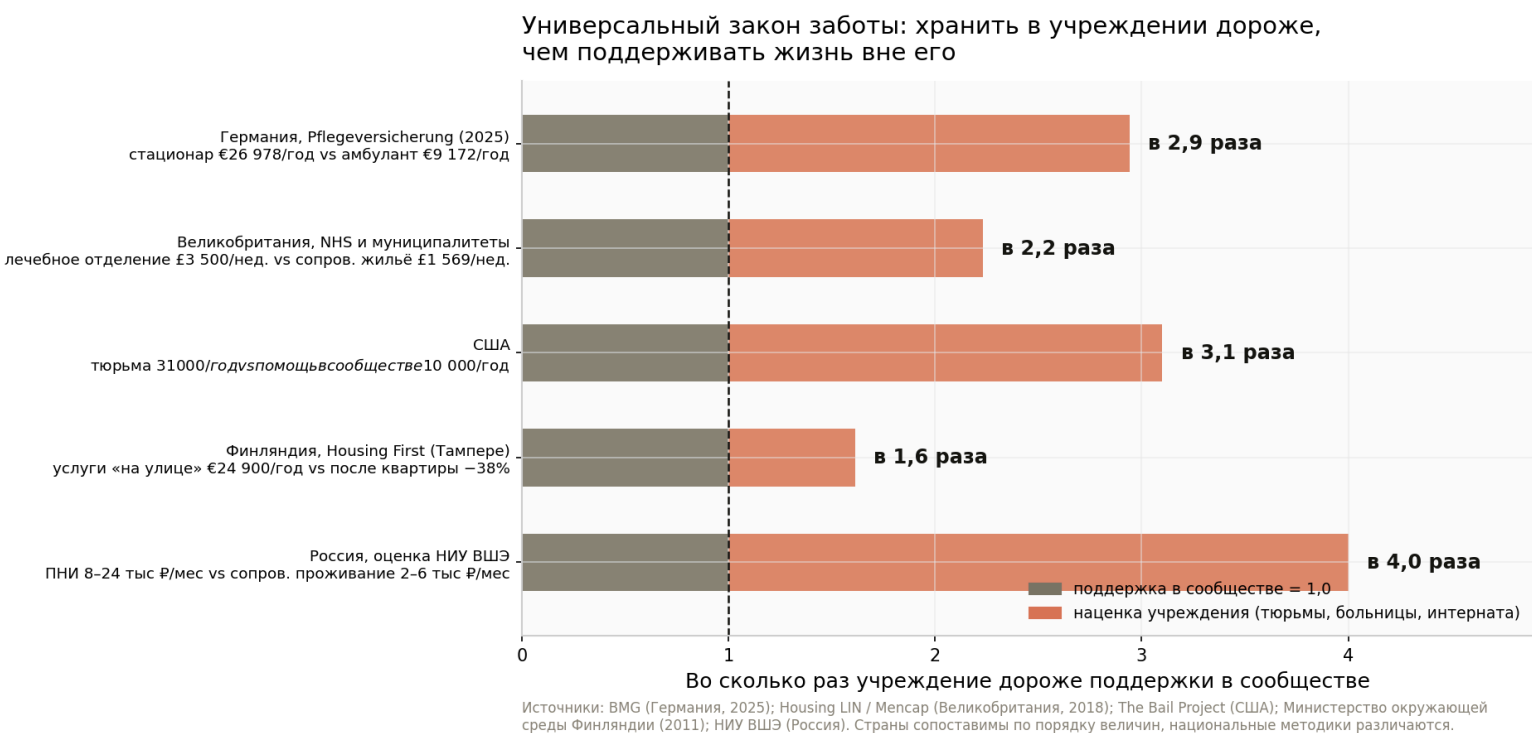


Рисунок 6.1. Соотношение цены учреждения и цены поддержки в пяти системах

Теперь переведём единицы в российскую смету. Диапазоны — по данным части 5 (ВШЭ, тарифы регионов, кейсы пилотов); точные цифры посчитайте на своих тарифах — порядок важнее точности.

Таблица 6.1. Ориентировочная смета единиц услуги в российском регионе (оценка по данным части 5)

| Единица                                 | Что входит                                                                   | Цена в месяц            | Цена в год     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Час сопровождения                       | Труд специалиста + налоги + транспорт + администрирование                    | —                       | 350–600 ₽/час  |
| Пакет «12 часов в неделю»               | Стандартная потребность «лёгкой» группы (Нижний Новгород; у 20% жителей ПНИ) | 17–31 тыс ₽             | 0,2–0,37 млн ₽ |
| Сопровождаемое проживание, групповое    | Доля человека в квартире на 7–8 с общим сопровождением (оценка ВШЭ)          | 2–6 тыс ₽               | 24–72 тыс ₽    |
| Сопровождаемое проживание, малые группы | Квартира на 3–4 (рекомендация Минтруда): сопровождение дороже, качество выше | 5–10 тыс ₽              | 60–120 тыс ₽   |
| Квартира на 3–4                         | Аренда/соцнайм + коммуналка + сопровождение группы                           | 40–90 тыс ₽ на квартиру | 0,5–1,1 млн ₽  |
| Место в ПНИ                             | Полное содерж                                                                | 8–24 тыс ₽              | 96–288 тыс ₽   |

|                                |                                  |              |               |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| Место в частном ПНИ            | Рыночная цена полного пансиона   | 33–51 тыс Р  | 0,4–0,6 млн Р |
| Койка психиатрической больницы | Койко-день по преискурентам × 30 | 33–145 тыс Р | 0,4–1,7 млн Р |

**Как читать смету.** Разница между «2–6 тысячами» ВШЭ и полным индивидуальным пакетом — не противоречие, а арифметика группы: один сопровождающий на квартиру из 7–8 человек делит стоимость часа на всех. Индивидуальный пакет 12 ч/нед — верхняя граница для жителя с высокой потребностью. Ключевая строка — «квартира на 3–4»: она дороже «сопровождаемого проживания», потому что включает жильё. Но сравнивать её надо с полной ценой альтернативы для этого же человека: место в ПНИ + потерянная пенсия + потерянная жизнь. При переносе 75% пенсии на аренду (часть 5.2) квартира почти самоокупается.

## 6.2. Три сценария: сохранение, модернизация, трансформация

### Сценарий А. Сохранение

**0 Р сверху**

Ничего не меняем: места финансируются как места, 75% пенсии у учреждения, корпуса стареют. Цена сценария — не ноль, а **отложенные издержки**: риск скандала по типу Уинтербоурн-Вью (с ценой репутации и уголовных дел), капремонты казарменных корпусов, демография проживающих и персонала. Каждый год сохранения — ещё один год хранения людей, из которых 20% могли бы жить своей жизнью за четверть цены.

### Сценарий Б. Точечная модернизация (1–2 ≈ 10% бюджета ПНИ в год года)

Обследование всех жителей (нижегородский метод) → тренировочная квартира (свердловский) → 2–3 квартиры сопровождаемого проживания для первой группы → субсидии первым работодателям (ленобластский) → региональный нормативный акт (ямальский). Результат: 15–30 человек вне стен, доказательная база для Минфина, обученная команда. Это сценарий «стартовать завтра».

**Сценарий В. Трансформация (5 лет)****переходный фонд 5 лет**

Перевод до 45% проживающих в малые квартиры с сопровождением; перепрофилирование части корпусов в малые дома; кейс-менеджеры; кооперативные рабочие места. Требуется переходного фонда на годы двойного финансирования (старые места + новые квартиры) и — в идеале — федерального решения по пенсиям. Экономика — ниже, в условном регионе N.

**6.3. Условный регион N: считаем вместе**

Возьмём регион с ПНИ на **400 мест** и средним содержанием 16 тыс ₽/месяц на человека (середина диапазона ВШЭ). Годовой бюджет интерната:  $400 \times 16\,000 \times 12 = 76,8$  млн ₽.

**Сценарий Б на цифрах (первый год)**

Таблица 6.2. Смета первого года точечной модернизации (оценка)

| Статья                                           | Сумма, млн<br>₽/год | Комментарий                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Обследование 400 жителей (команда 5 чел, 6 мес)  | 2,0                 | нижегородский метод; результат — карта потребностей в часах    |
| Тренировочная квартира (аренда + ремонт)         | 0,9                 | свердловский/тюменский опыт                                    |
| 3 квартиры на 12 человек: аренда + сопровождение | 2,1                 | $12 \times 6$ тыс ₽ сопровождение + аренда $3 \times 35$ тыс ₽ |
| Субсидии 5 работодателям                         | 2,5                 | разовые, из программ занятости (ленобластский опыт)            |
| <b>Итого год 1</b>                               | <b>7,5</b>          | <b>≈10% бюджета ПНИ; 15–20 человек вне стен</b>                |

**Сценарий В на цифрах (год 5, устойчивое состояние)**

Переводим 180 человек (45% от 400) в квартиры. Два варианта — и разница между ними показывает, где лежит главный федеральный рычаг.

Таблица 6.3. Экономика перевода 180 человек, млн ₽/год (оценка)

| Вариант | Аренда | Сопровождение | Кейс-менеджеры | Итого | Было (180 мест ПНИ) | Эффект |
|---------|--------|---------------|----------------|-------|---------------------|--------|
|---------|--------|---------------|----------------|-------|---------------------|--------|

|                                                            |          |             |            |             |             |                             |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Группы 7–8, пенсия у учреждения                            | 9,7      | 8,6         | 4,3        | 22,6        | 34,6        | –12,0 (экономия 35%)        |
| Малые группы 3–4, пенсия у учреждения                      | 18,9     | 17,3        | 4,3        | 40,5        | 34,6        | +5,9 (дороже на 17%)        |
| <b>Малые группы 3–4, пенсия у человека (датская норма)</b> | <b>0</b> | <b>17,3</b> | <b>4,3</b> | <b>21,6</b> | <b>34,6</b> | <b>–13,0 (экономия 38%)</b> |
| <b>(платит жилец из пенсии)</b>                            |          |             |            |             |             |                             |

**Главный вывод калькулятора.** При нынешней норме «75% пенсии — учреждению» качественная модель (малые группы по 3–4, как рекомендует Минтруд) в устойчивом состоянии **дороже** интерната на ~17%; бюджетная экономия достигается только ценой укрупнения групп до 7–8 — то есть ценой качества. «Датская норма» (пенсия — человеку, аренду платит жилец) снимает дилемму полностью: малые группы становятся **и дешевле на 38%, и лучше**. Именно поэтому пенсионный вопрос из части 5.2 — не гуманитарная добавка, а ключ к экономике всей реформы. И не забудьте переходный период: 2–3 года двойного финансирования (места ещё есть, квартиры уже оплачены) потребуют переходного фонда порядка 5–10 млн ₽/год для нашего региона N.

## 6.4. Шесть источников денег без новых денег

Таблица 6.4. Механизмы финансирования реформы из существующих потоков

| Источник                   | Где сработал                                                  | Механика для региона                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Перенаправление бюджета | Бразилия: доля общинного финансирования 24,8% → 79,4%         | Норматив «на человека с потребностью» вместо «на место»; деньги следуют за переведённым жителем из статьи ПНИ в статью сопровождения |
| 2. Пенсия жителя → аренда  | Дания, закон 1987 года                                        | Полная пенсия человеку; аренду и коммуналку платит жилец. Федеральный уровень; регион готовит расчёт и пилотный запрос               |
| 3. Социальные облигации    | Челябинская область (ВЭБ.РФ/РМК); Golden Lane Housing £21 млн | Инвестор финансирует программу; регион платит из достигнутой экономии за измеримый результат (число переведённых, качество жизни)    |
| 4. Программы занятости     | Ленинградская область: 500 тыс. ₽ работодателю                | Субсидия за рабочее место для человека из ПНИ — из существующих линий поддержки занятости, без новой статьи                          |

|                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Высвобождение активов</b>     | Москва: сокращение коечного фонда 118 → 62 на 100 тыс с перепрофилированием корпусов                            | Избыточные корпуса — в малые дома, соцнайм или продажу/аренду с направлением выручки в программу. Казарменный фонд — актив, а не балласт             |
| <b>6. Экономия смежных бюджетов</b> | Финляндия: €9 600–15 000/год на человека (скорая, полиция, тюрьмы); США: \$31 000 тюрьма vs \$10 000 сообщество | Соглашение с Минздравом и МВД: считаем вызовы скорой, сутки в больнице, дела полиции до/после; экономия делится на программу (межбюджетный «эскроу») |

## 6.5. Переговорная таблица: запрос директора → мировая цена → наш аналог

Рабочий инструмент для министра: на каждый «западный» запрос — его реальная мировая цена и работающий российский аналог по цене нашего этажа.

Таблица 6.5. Переговорная матрица

| Запрос                                   | Мировая цена                                           | Российский аналог и его цена                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Сопровождаемое проживание как в Англии» | £1 569/нед ≈ £81,6 тыс/год (≈8,6 млн ₽)                | Квартира на 3–4 + сопровождение: 0,15–0,2 млн ₽/год на человека (Нижний, Ленобласть)       |
| «Дома как в Хохевейке»                   | ≈€5 000/мес (≈5,7 млн ₽/год) + строительство €19,3 млн | Малый дом при ПНИ на 10–14 мест: перепрофилирование корпуса (Курган)                       |
| «Персональные бюджеты как в UK»          | £1,8 млрд/год прямых выплат                            | Социальный контракт + целевые выплаты получателю: пилот на 10–20 семьях                    |
| «Страхование ухода как в Германии»       | €63,3 млрд/год, 30 лет взносов                         | Федеральная повестка; региону — отдельная «строка ухода» в бюджете для видимости риска     |
| «Reablement как в Дании»                 | 3–12 недель команды на человека                        | Тренировочная квартира: 0,9 млн ₽/год (Свердловск, Тюмень)                                 |
| «Пособие семье как Pflegegeld»           | €18,6 млрд/год, 27% расходов системы                   | Выплата семье, забравшей подопечного: 2–6 тыс ₽/мес — дешевле места вчетверо               |
| «Кейс-менеджеры как в Японии»            | Армия сертифицированных care managers                  | Переаттестация 3–6 соцработников ПНИ + методика пилота Минтруда                            |
| «Закреть интернат, как в Италии»         | Закон 180/1978; все больницы закрыты к 1999 году       | Не закрытие, а перепрофилирование: корпуса → малые дома + квартиры (дорожная карта Тюмени) |

*Правило переговоров: никогда не спорьте о «стандартах» — спорьте о цене единицы и о том, какая единица нужна конкретному человеку. В этой системе координат выигрывают оба: и министр, и директор, и — главное — житель.*

# Пространство новых идей: куда идти

Наш семинар называется «Пространство Новых Идей». Эта часть — про идеи, у которых уже есть адреса, ценники и сроки. Будущее социального обслуживания не наступит само — но его уже строят. В том числе в России.

## 7.1. Мировой вектор 2035 года

Наложите карты всех восьми кейсов части 3 — и увидите одно направление, по которому идут и чемпионы, и догоняющие:

- **От интерната к квартире.** Нормальное жильё становится базовой «производственной площадкой» заботы (Хохевейк, Дания, Housing First, сопровождаемое проживание в 84 регионах РФ).
- **Деньги за человеком.** Финансирование привязывается к сертифицированной потребности, а не к учреждению (Pflegegrade, персональные бюджеты UK, Бразилия).
- **От обслуживания к тренировке.** Задача системы — не «делать за», а «научить и поддержать» (reablement Дании, тренировочные квартиры Урала и Тюмени).
- **Малые формы вместо казарм.** 6–8 человек, квартирная планировка, персонал без халатов — новый мировой стандарт жилой формы.
- **Работа вместо занятости.** Социальные кооперативы Италии, пекарня Усадьбы Аристовых, субсидии работодателям Ленобласти — доход человека вместо имитации труда.
- **Честная цена ухода.** Все развитые системы признали уход отдельным бюджетным риском и научились его считать: от 1,5% ВВП (среднее ОЭСР) до 3,9% (Нидерланды). Россия — пока в зоне «невидимых» 0,1–0,2%; сделать эти расходы видимыми — первый шаг к их росту.

## 7.2. Заделы на будущее: что уже готово к масштабированию

### Технологии

- **Телеуход и умная квартира:** датчики, вызов, напоминания — снижают потребность в «дежурном присутствии», самом дорогом элементе поддержки. UK прямо считает telecare источником дополнительной экономии в сопровождаемом жильё.
- **3D-тренажёры быта** (Тюмень): обучение навыкам до выхода в реальную квартиру — дешевле и безопаснее «боевого» старта.

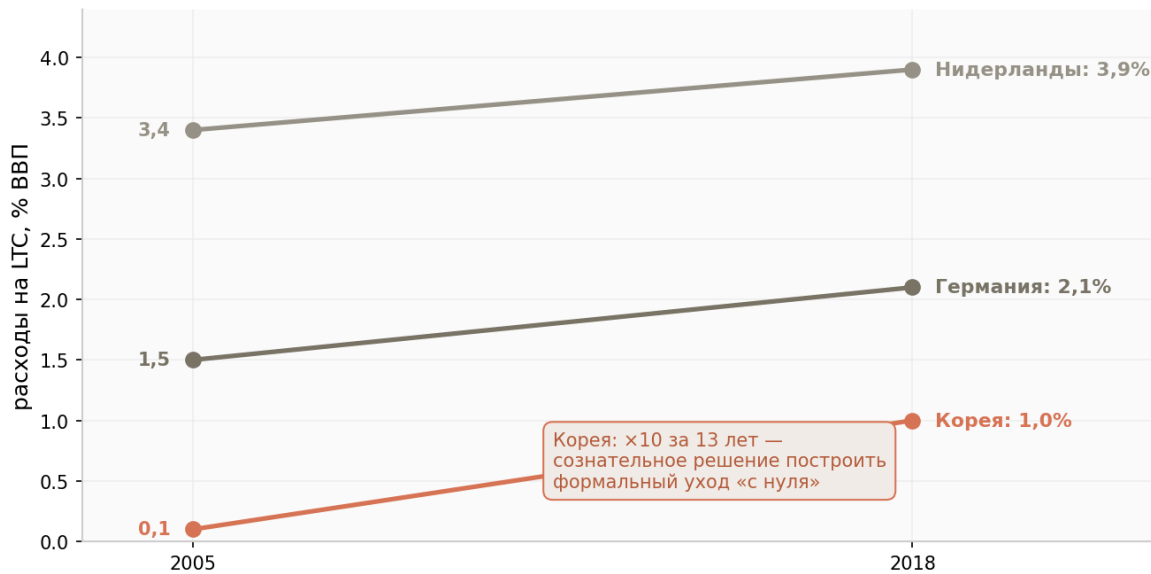
### Организация

- **Персональные бюджеты:** получатель покупает помощь сам — прямые выплаты UK (£1,8 млрд) и Pflegegeld (€18,6 млрд) — крупнейшие «малые» механизмы двух систем.
- **Социальные кооперативы:** 4 500+ в Италии; юридическая форма «дом + производство» уже проверена в России (Усадьба Аристовых).
- **Социальные облигации:** деньги развития под результат (Челябинск, GLN £21 млн).

## 7.3. Корейский сценарий для России

Республика Корея в 2005 году тратила на длительный уход 0,1% ВВП — как Россия сейчас, по нашей оценке. За 13 лет — ×10, до 1% ВВП: национальное страхование ухода (2008), рост расходов более 25% в год в реальном выражении, лавинообразное лужб.

Ступени можно перепрыгивать: Корея прошла путь «от семьи к системе» за 13 лет



Источник: OECD Health Statistics 2020 («Spending on long-term care», 2020). Расходы Кореи росли более чем на 25% в год в реальном выражении; в 2008 г. введено национальное страхование ухода.

Рисунок 7.1. Ступени лестницы можно перепрыгивать

Корея не ждала, пока «дорстет» до скандинавского уровня жизни, — она приняла **политическое решение формализовать заботу** на своём уровне доходов. Россия в 2023–2025 сделала первые шаги того же типа: 137-ФЗ, пилот Минтруда, 84 региона с практиками. Корейский сценарий говорит: после «закрепления понятия» приходит этап «денег и стандартов» — и именно на него регионам стоит готовить задел уже сейчас: обследованные когорты, методики, кадры, жилфонд.

## 7.4. Дорожная карта региона: пять шагов

### Обследование вместо деклараций

**шаг 1 · 3–6 мес**

Междисциплинарная оценка всех жителей ПНИ: потребность в часах, навыки, жильё, семья, дееспособность. Результат — карта когорт: «лёгкие» ( $\leq 12$  ч/нед), «средние», «тяжёлые». Нижегородский опыт: это дёшево и сразу меняет разговор с Минфином.

### Юридический пакет

**шаг 2 · 6–12 мес**

Региональный акт о сопровождаемом проживании (модель — ЯНАО 1064-П + материалы пилота Минтруда), норматив «на человека», порядок тренировочных квартир, субсидия работодателям (модель — Ленобласть).

### **Первая волна: 15–30 человек**

**шаг 3 · год 1–2**

Тренировочная квартира → 2–5 квартир сопровождаемого проживания для «лёгкой» когорты → первые рабочие места. Кейс-менеджер из числа лучших соцработников. Метрики: качество жизни (методика ВОЗ), цена на человека, вызовы экстренных служб.

### **Масштабирование и активы**

**шаг 4 · год 2–4**

Перепрофилирование корпусов в малые дома; жилфонд (соцнайм, аренда с субсидией, восстановление сиротских прав); социальная облигация под результат (модель — Челябинск); кооператив «дом + производство» (модель — Усадьба Аристовых).

### **Новая система**

**шаг 5 · год 4–5**

ПНИ как сеть малых форм; финансирование за человеком; цель по Минтруду — до 45% проживающих в форматах самостоятельной жизни. Региональный расчёт по датской норме — на стол федеральному центру как готовое предложение.

## **7.5. Что можно сделать завтра без денег**

1. **Назначить ответственного** за сопровождаемое проживание на уровне замминистра/замдиректора — с календарём, а не «в нагрузку».
2. **Открыть двери:** дни семей, волонтерские визиты, публичная страница ПНИ. Открытость — самая дешёвая защита от Уинтербоурн-Вью.
3. **Снять белые халаты** с не-медицинского персонала: Хохевейк доказал — одежда меняет отношения.
4. **Пересадить по биографиям, а не по диагнозам:** малые группы со схожим укладом жизни в существующих комнатах — первый шаг к «домам» без стройки.
5. **Запустить «час обучения» вместо часа обслуживания:** готовка, бюджет, транспорт — навук, а не услуга (принцип reablement).
6. **Посчитать свой регион N** по таблицам 6.2–6.3: два часа работы экономиста — и у вас есть цифры для разговора с Минфином.
7. **Найти первую квартиру:** муниципальный фонд, пустующее служебное жильё, договор с застройщиком о социальной аренде.

8. **Позвонить в два региона из части 5.4:** все они охотно делятся документами — не изобретайте постановление, берите готовое.

## 7.6. Финал: почему это реально

Подведём итог без громких слов. Мир за пятьдесят лет проделал путь от Лероса — до Хожевейка. На этом пути доказано три вещи. **Первое:** люди, которых десятилетиями считали «нежилыми», живут самостоятельной жизнью — в Триесте, Хельсинки, Нижнем Новгороде, Челябинске. **Второе:** это дешевле хранения почты везде, где посчитано, — от £185 в неделю экономии английскому графству до 38% в нашем условном регионе N. **Третье:** решает не богатство страны, а архитектура решений: Бразилия сделала это в наших бюджетных координатах, Корея — за 13 лет «с нуля», Курганская область — на базе действующего ПНИ.

У России уже есть закон (137-ФЗ), пилот Минтруда, восемь работающих региональных моделей и потенциал в 70–100 тысяч человек. Нет ни одного барьера из шести, который не был бы пройден кем-то раньше — в другой стране или в соседнем регионе. Осталось соединить карту, калькулятор и решимость.

*Пространство новых идей — это не про то, где взять больше денег. Это про то, как на имеющиеся деньги купить больше жизни. Всё для этого уже изобретено. Осталось применить.*

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложения

## Приложение А. Глоссарий для переговоров

Термины, которые встречаются в докладе и в мировой практике, — в переводе на язык сметы и договора.

Таблица А.1.

| Термин                                      | Что это значит на практике                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Долговременный уход (ЛТС)</b>            | Всё, что нужно человеку, который не справляется с бытом из-за состояния здоровья: помощь с едой, гигиеной, жильём, передвижением, общением. Не лечение — а жизнь рядом с лечением. Именно ЛТС, а не медицина, — ядро бюджета соцобслуживания.          |
| <b>Деинституционализация</b>                | Переход от больших казённых учреждений к жизни в обычном жилье с поддержкой. Не «закрыть интернат», а «переместить услугу к человеку» — с деньгами, штатом и контролем качества.                                                                       |
| <b>Сопровождаемое проживание</b>            | Российское название модели: человек живёт в квартире (один или в малой группе 3–4), специалисты приходят по индивидуальному плану — от нескольких часов в неделю до круглосуточно. Квартира не принадлежит учреждению идеологически: это дом человека. |
| <b>Supported living / supported housing</b> | Британские аналоги. Важная разница: жильё и уход — два разных договора с разными поставщиками. Если поставщик ухода плох, его меняют, а человек остаётся в своём доме.                                                                                 |
| <b>Housing First</b>                        | «Сначала жильё»: человеку дают постоянное жильё без предварительных условий («сначала вылечись»), поддержка подключается следом. Финская модель, доказавшая экономию на полиции, скорых и ночлежках.                                                   |
| <b>Reablement</b>                           | Восстановление бытовой автономии: короткая (в Дании 3–12 недель) интенсивная программа после кризиса, цель — чтобы человеку вообще не понадобился постоянный уход или понадобился меньший. Вложение, которое сокращает будущие расходы.                |
| <b>Персональный бюджет / прямые выплаты</b> | Деньги идут не учреждению, а человеку (или его представителю), который сам нанимает помощников. В Англии — direct payments, в Германии — Pflegegeld. Меняет власть: учреждение конкурирует за клиента, а не наоборот.                                  |
| <b>ИППСУ</b>                                | Индивидуальная программа предоставления социальных услуг — российский документ, определяющий виды и объём помощи. Бумажный аналог персонального плана поддержки; его качество — качество всей системы.                                                 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Норма 25/75</b>                           | В российских интернатах 75% пенсии жителя удерживается на содержание, 25% остаётся человеку. Ключевая экономическая переменная реформы: в Дании житель дома для престарелых — полноправный квартиросъёмщик со 100% пенсии, уход оплачивается отдельно. |
| <b>Трансинституционализация</b>              | Ложная деинституционализация: человек покидает интернат, но попадает не в жизнь, а в другую «тотальную организацию» — тюрьму, ночлежку, частный пансион без контроля. Главный риск плохо подготовленной реформы (см. США).                             |
| <b>Койко-день</b>                            | Медицинская единица оплаты: сутки пребывания в стационаре. В соцобслуживании лучше не использовать — слово программирует мышление «кроватями», а не услугами.                                                                                          |
| <b>Care home / nursing home</b>              | В Британии различают: care home — дом с бытовой поддержкой (без постоянного медперсонала), nursing home — с круглосуточным сестринским уходом. Цены различаются вдвое; путаница в терминах портит любую смету.                                         |
| <b>Eigenanteil</b>                           | Немецкая «собственная доплата» жителя дома престарелых сверх страхового покрытия (в среднем ~€2 977 в месяц в 2025 году). Напоминание: даже богатые системы не покрывают уход целиком — вопрос лишь в том, кто и как делится расходами.                |
| <b>Муниципализация ухода</b>                 | Передача ответственности с национального уровня на муниципалитеты (Нидерланды-2015, Скандинавия). Плюс: решения ближе к человеку. Минус: разрыв между богатыми и бедными территориями — то, что России надо нивелировать выравнивающими субсидиями.    |
| <b>Социальный заказ / конкурентный рынок</b> | Государство покупает услугу у разных поставщиков — государственных, НКО, частных — по единым стандартам качества. Сам по себе не экономит; экономит связка «конкуренция + контроль» (см. урок Winterbourne View).                                      |
| <b>Тренировочная квартира</b>                | Квартира при ПНИ, где жители под контролем осваивают быт перед самостоятельным выходом. Дешёвый первый шаг реформы, не требующий ни закона, ни строительства (см. Свердловскую область).                                                               |
| <b>Сопровождаемая занятость</b>              | Поддержка человека на обычном рабочем месте: job-coach помогает и работнику, и работодателю. Практикуется уже в 69 регионах России; Ленобласть субсидирует работодателю до 500 тыс Р.                                                                  |
| <b>Социальная кооперация</b>                 | Итальянская форма: кооператив, где не менее 30% работников — люди с инвалидностью, получает социальные контракты. В Италии их 4 500+, они — заметный работодатель и поставщик услуг.                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>АСТ / бригадная помощь</b>           | Assertive Community Treatment — мобильная мультидисциплинарная бригада (психиатр, соцработник, реер-специалист) для людей с тяжёлыми расстройствами вне стационара. Ядро модели Триеста. |
| <b>Recovery-подход</b>                  | «Восстановление» — цель не в отсутствии симптомов, а в осмысленной жизни: жильё, отношения, дело, роль в сообществе. Изменение критерия успеха меняет и структуру расходов.              |
| <b>Пакет часов</b>                      | Единица планирования: не «место в интернате», а «N часов поддержки в неделю под конкретный план». Перевод системы на часы — техническая основа любого современного тарифа.               |
| <b>Переходный фонд (double running)</b> | Деньги на период, когда старая система ещё работает, а новая уже строится: два бюджета одновременно, обычно 2–3 года. Без этой строки в смете реформы не начинаются — ломаются.          |
| <b>Реер-специалист</b>                  | Сотрудник с личным опытом расстройства и восстановления, работающий в команде поддержки. Дёшево, доказанно эффективно, пока редко в России.                                              |

## Приложение Б. Курсы валют и порядок величин

Все зарубежные цифры доклада приведены в национальных валютах, а рублёвые эквиваленты даны по округлённым средним курсам соответствующего года. Их задача — порядок величины для сметы, а не бухгалтерская точность.

Таблица Б.1.

| Год (средний)        | доллар США | евро    | фунт стерлингов | 100 иен |
|----------------------|------------|---------|-----------------|---------|
| 2023                 | ≈ 85 ₽     | ≈ 92 ₽  | ≈ 106 ₽         | ≈ 61 ₽  |
| 2024                 | ≈ 93 ₽     | ≈ 100 ₽ | ≈ 118 ₽         | ≈ 61 ₽  |
| 2025                 | ≈ 82 ₽     | ≈ 92 ₽  | ≈ 107 ₽         | ≈ 55 ₽  |
| 2026 (1-е полугодие) | ≈ 78 ₽     | ≈ 88 ₽  | ≈ 102 ₽         | ≈ 52 ₽  |

Округлённые средние курсы Банка России и рыночных площадок. Важная оговорка: сравнивать «что можно купить внутри страны» корректнее по паритету покупательной способности — по ППС доллар стоит заметно меньше рублей, то есть рублёвые бюджеты «тянут» больше, чем кажется по биржевому курсу. Но зарплата персонала ухода — главная статья расходов — соотносится между странами ещё сильнее, поэтому цены часа ухода из части 2 пересчитаны и в процентах от средней зарплаты.

## Приложение В. Как оценивались расходы России на долговременный уход

В российской статистике нет строки «долговременный уход» в методологии ОЭСР, поэтому оценка 0,1–0,2 % ВВП из части 2 — расчётная, снизу вверх. Ход расчёта:

- 1. Стационарное социальное обслуживание.** ПНИ: около 190 тысяч жителей × в среднем 16 тысяч ₽/мес × 12 месяцев ≈ **36 млрд ₽/год**. С учётом домов-интернатов

для престарелых и инвалидов и капитальных затрат — **120–150 млрд ₽/год** на все стационарные учреждения соцобслуживания.

2. **Надомное и полустационарное обслуживание:** по данным региональных отчётов о соцобслуживании — порядка **40–60 млрд ₽/год**.

3. **Итого прямые бюджетные расходы:** 160–210 млрд ₽ при ВВП около 200 трлн ₽ (2024) — **~0,08–0,11 % ВВП**. Добавляя часть долгого пребывания в психиатрических больницах (медицинская статистика, но по сути — уход) и оплачиваемый частный уход, получаем **0,1–0,2 % ВВП** — в 10–20 раз меньше, чем у лидеров ОЭСР.

**Честные ограничения оценки.** Три четверти реальных затрат российской системы лежат вне бюджета: неоплачиваемый труд семей (у ОЭСР он тоже есть, но там он частично замещён услугами), удержанные 75 % пенсий жителей интернатов и скрытый уход в медицинских стационарах. Поэтому разрыв с миром по *полным* затратам меньше, чем 10–20 раз, — но разрыв по *качеству и выбору* больше: деньги семей не покупают ни профессиональности, ни передышки.

## Приложение Г. Источники

### МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЗОРЫ

OECD (2020). Spending on Long-term Care. OECD Health Policy Studies, Paris. doi.org/10.1787/e1f00970-en

OECD (2025). Health at a Glance 2025: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris — oecd.org

OECD / European Observatory on Health Systems and Policies (2021). Denmark: Country Health Profile 2021. health.ec.europa.eu

World Bank (2024–2026). World Development Indicators — data.worldbank.org

### ГЕРМАНИЯ

Bundesministerium für Gesundheit (2025). Zahlen, Daten und Fakten zur Pflegeversicherung (Geschäftsstatistik der Pflegekassen zum 31.12.2024).

bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3\_Downloads/Statistiken/Pflegeversicherung/Zahlen\_und\_Fakten/Zahlen\_und\_Fakten\_Pflegeversicherung.pdf

AOK (2026). Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung. aok.de/pp/hintergrund/pflege/zahlen-fakten-pflegeversicherung

Statistisches Bundesamt. Pflegestatistik und Pflegevorausberechnung (прогноз числа нуждающихся в уходе до 2055 г.) — destatis.de

### ЯПОНИЯ

MHLW — Ministry of Health, Labour and Welfare (2023). Статистика расходов на уход за 2022 фин. год: сводка — Nippon.com, «Japan Spends Over ¥11 Trillion on Nursing Care in Fiscal 2022».

nippon.com/en/japan-data/h01825

Japan Health Policy NOW (2017). Japan's Long-Term Care Insurance System. japanhpn.org/en/section-3-2

Ikegami N. (2019). Financing Long-term Care: Lessons From Japan. Health Affairs — pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6706968

MHLW (2024–2025). Оценки расходов на социальное обеспечение к 2040 фин. году — [mhlw.go.jp](https://mhlw.go.jp)

#### ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Department of Health and Social Care (2025). Adult social care finance report, England: 2024 to 2025 (панель — NHS England ASC-FR). [gov.uk/government/statistics/adult-social-care-finance-report-england-2024-to-2025](https://gov.uk/government/statistics/adult-social-care-finance-report-england-2024-to-2025)

Mencap / Housing LIN (2018). Funding supported housing for all: Specialised Supported Housing for people with a learning disability. [mencap.org.uk](https://mencap.org.uk)

Housing LIN (2025). Supported housing for people with learning disabilities and autistic people in England. [housinglin.org.uk](https://housinglin.org.uk)

Bancalari A., Karjalainen H., Stoye G. / IFS (2024). Adult social care in England: what next? [ifs.org.uk/publications/adult-social-care-england-what-next](https://ifs.org.uk/publications/adult-social-care-england-what-next)

The Health Foundation (2024–2025). Оценки дефицита финансирования соцобслуживания Англии к 2032/33 — [health.org.uk](https://health.org.uk)

National Audit Office (2017). Local support for people with a learning disability — [nao.org.uk](https://nao.org.uk)

BBC Panorama (31.05.2011). Undercover Care: The Abuse Exposed (Winterbourne View) — [bbc.co.uk](https://bbc.co.uk)

Care Quality Commission (2020–2024). Right support, right care, right culture; материалы Transforming Care — [cqc.org.uk](https://cqc.org.uk)

Nuffield Trust (2025). Long-term care: Denmark case study. [nuffieldtrust.org.uk](https://nuffieldtrust.org.uk)

#### НИДЕРЛАНДЫ

Vivium / Hogeweyk. The Hogeweyk: Dementia Village (материалы деревни, Веесп) — [hogeweyk.dementiavillage.com](https://hogeweyk.dementiavillage.com)

Rijksoverheid (2015). Decentralisaties in het sociale domein (Wmo 2015; Jeugdwet; Participatiewet) — [rijksoverheid.nl](https://rijksoverheid.nl)

#### ФИНЛЯНДИЯ

Kaakinen J. / Y-Foundation, World Economic Forum (2018). Here's how Finland solved its homelessness problem. [weforum.org/stories/2018/02/how-finland-solved-homelessness](https://weforum.org/stories/2018/02/how-finland-solved-homelessness)

Housing Europe (2024). Housing First briefing — the case of Finland. [housingeurope.eu](https://housingeurope.eu)

Ministry of the Environment, Finland (2011–2012). Оценка экономии программы PAAVO I по модели «Сначала жильё» — [um.fi](https://um.fi)

ARA Finland (2023–2025). Статистика бездомности (PAAVO, Housing First) — [ara.fi](https://ara.fi)

#### ИТАЛИЯ

Legge 13 maggio 1978, n. 180 («закон Базальи») — [normattiva.it](https://normattiva.it)

Portacolone E. et al. (2015). Опыт психиатрической реформы Триеста (серия обзоров системы Trieste СМНС, 2013–2016).

Mezzina R. (2014–2020). Публикации Департамента психического здоровья Триеста о деинституционализации и социальных кооперативах.

#### США

Treatment Advocacy Center (2016). Serious Mental Illness (SMI) Prevalence in Jails and Prisons — [treatmentadvocacycenter.org](https://treatmentadvocacycenter.org)

Treatment Advocacy Center (2014). The Treatment of Persons with Mental Illness in Prisons and Jails: A State Survey.

The Bail Project (2021–2023). Материалы о тюрьме Райкерс и системе залога — [bailproject.org](https://bailproject.org)

## ГРЕЦИЯ

The Observer (10.09.1989). Europe's Guilty Secret (репортаж о Леросе).

Springer (2026). Глава о проекте деинституционализации Лероса и его отсроченных итогах (психиатрическая реформа в Греции).

BBC (2009–2010). Репортажи об условиях в греческих психиатрических учреждениях (Dromokraitio; пансион Athina) — [bbc.co.uk](http://bbc.co.uk)

## СКАНДИНАВИЯ

Lov om boliger for ældre og handicappede (Дания, 1987) — запрет классических «богаделен»; [retsinformation.dk](http://retsinformation.dk)

Bristol University Press / Policy Press (2023–2025). Исследования приоритизации и сокращения охвата долговременного ухода в Скандинавии (Nordic care crisis).

Nuffield Trust (2025). Denmark case study (см. выше).

## БРАЗИЛИЯ И РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 (психиатрическая реформа Бразилии); Ministério da Saúde — динамика коек и сети CAPS; программа «Volta para Casa».

National Health Insurance Service, Korea. Long-Term Care Insurance — [nh.or.kr](http://nh.or.kr); OECD (2020), раздел о Корее.

## РОССИЯ

Федеральный закон № 137-ФЗ (2023) — правовая база сопровождаемого проживания и экспериментов в соцобслуживании.

Минтруд России (2022–2025). Материалы пилотных проектов по сопровождаемому проживанию (Воронежская, Нижегородская области); сводная практика 84 регионов — [mintrud.gov.ru](http://mintrud.gov.ru)

НИУ ВШЭ (2023–2025). Исследования экономики ПНИ и сопровождаемого проживания; измерение качества жизни (WHOQOL) — [hse.ru](http://hse.ru)

Проект «Если быть точным» / Vademec (2024–2026). Отчёты о системе ПНИ, удержании пенсий и практиках сопровождаемого проживания.

Региональные источники: Комитет социальной защиты Ленинградской области (Мультицентр); Минсоцзащиты Свердловской области (тренировочные квартиры, «Усадьба Аристовых»); ВЭБ.РФ и ГК РМК (проект социального воздействия, Челябинская область); Департамент социального развития Тюменской области (дорожная карта 2020–2024); Депсоцзащиты ХМАО (Излучинский дом-интернат, Модельная программа 18–55); соцзащита Курганской области (Галишевский ПНИ); Постановление правительства ЯНАО № 1064-П (2021); минсоцполитики Нижегородской области (обследование жителей ПНИ, 2023–2024).

Всемирный банк — данные по расходам на здравоохранение и ВВП (см. выше); тарифы койко-дня — преискурранты региональных психиатрических больниц (РКПБ Татарстана и др.).